

Douleurs thoraciques

Anamnèse

1. Douleurs thoraciques
 - a. Localisation
 - b. Irradiation
 - c. Intensité
 - d. Qualité
 - e. Facteurs aggravants (respiration-dépendant)
 - f. Facteurs soulageants (position dépendant)
 - g. Chronologie
 - i. Depuis quand
 - ii. Évolution
 - iii. Condition de survenues (trauma, sport, ...)
2. Dyspnée
 - a. Condition de survenue
 - b. Classification (périmètre de marche, nb étage etc)
 - c. Chronologie
3. Symptômes associés
 - a. Toux
 - i. Depuis quand
 - ii. Fréquence
 - iii. Qualité (sèche, grasse)
 - iv. Expectoration
 1. Couleur
 2. Sang
 - b. Hémoptysie
 - c. Douleurs ou œdèmes des membres inférieurs (EP)
 - d. Orthopnée – dyspnée paroxystique nocturne
 - e. Nycturie
 - f. Palpitation**
 - g. Fièvre**
4. Facteurs de risques
 - a. Tabagisme
 - b. Voyages récents (> 6h, pays?)
 - c. Chirurgie, immobilisation récente – cancer
 - d. Médicaments, contraceptions – grossesse (EP)
 - e. ATCD EP, thrombose, phlébite,
 - f. ATCD angine de poitrine
 - g. ATCD AVC
5. ATCD et comorbidités
 - a. Maladie : **diabète, hypercholestérolémie, HTA**
 - b. Hospitalisations
 - c. Opération (récente ?)
 - d. Médicaments
 - e. Allergies
6. ATCD familiaux

Signes d'alarme

- Sudations profuses
- TA < 90/60 mmHg
- Pouls > 120/min
- Tachypnée > 30/min
- Cyanose
- Arythmie nouvelle
- Signes cliniques de TVP (douleur, œdème d'un MI)
- Déficit neurologique
- Disparition des pouls aux MI
- Asymétrie de TA systolique aux MS (>11 mmHg)
- Déviation trachéale
- Turgescence jugulaire

Examen clinique

1. Inspection
 - a. Extrémités (ongles)
 - b. Langue
 - c. Recoloration capillaire
 - d. Thorax et mouvements
 - e. **Oedèmes des MI** (godet)
 - f. **Turgescence jugulaire (Reflux hépato-jugulaire (> 10s))**
2. Cardiaque
 - a. Palpation
 - i. Pouls périphériques aux 4 extrémités
 - ii. Carotidien (**!!! auscultation avant**)
 - iii. Choc de pointe
 - b. Auscultation
 - i. Aortique
 - ii. Pulmonaire
 - iii. Mitral
 - iv. Tricuspide
3. Pulmonaire
 - a. Palpation
 - i. Zone douloureuse (reproductible à la palpation ?)
 - ii. Ampliation thoracique (post)
 - b. Percussion (post + lat)
 - i. Délimiter
 - ii. Comparer les deux côtés
 - c. Auscultation
 - i. Antérieure
 - ii. Postérieure : 4 plages en comparant
 - iii. Latérales : 2 plages

Examen complémentaire :

- ECG
- Rx thorax (év CT, US)
- Laboratoire
 - FSC
 - Troponine si suspicion SCA
 - D-dimère si proba EP faible ou moyenne

DD

- *Cardiaque*
 - **SCA**
 - *Angor – angor instable* : douleur constrictive ne durant que qq minutes et répondant év. aux dérivés nitrés
 - *Infarctus du myocarde* : douleurs constrictive irradiants dans le bras et la mâchoire non soulagée par les dérivés nitrés, patient souvent figé avec des sudations profuses, signes d'IC, troponine positive
 - **Dissection aortique** : douleur transfixiante interscapulaire avec début brutal, en coup de poignard avec év. souffle diastolique d'insuffisance aortique, asymétrie tensionnelle aux 2 bras > 20 mmHg, abolition des pouls périphériques
 - **Tamponnade** : bruit lointain, hypotension
 - **Péricardite** : douleur peut être épisodique, d'apparition progressive, rétro-sternale – latérale gauche avec irradiation vers le cou – épaule gauche, soulagée par la position assise et la flexion du tronc, frottement péricardique
 - **Valvulopathie**
 - **Myocardite s**
- *Pulmonaire*
 - **Embolie pulmonaire** : douleur pleurale respiro-dépendante avec début brutal, dyspnée, polypnée, toux, hémoptysie, tachychardie et hypotension, ! peut entrainer une pleurésie qui peut faire une doul. reproductible à la palpation. Faire D-dimère seulement si probabilité faible ou intermédiaire, faire directement CT-scan si probabilité élevée
 - *Pathologie pleurale*
 - **Pneumothorax** : douleur aiguë respiro-dépendante, unilatéral, toux, homme, fume, fin, tympanisme, diminution murmure vésicale
 - **Pneumonie - bronchite** : fièvre, toux
 - **Pneumomédiastin**
- *Digestif*
 - *Œsophage*
 - **RGO** : douleur retrosternale, de type brûlure, soulagée par la nourriture, aggravée par le décubitus dorsal après les repas
 - **Spasme de l'œsophage** : région sternale, profonde, douleur mimant l'angor, ne dure que 2-3 min, associée aux liquides froids, ! peut être soulagée par la nitroglycérine !
 - **Déchirure** : brutal
 - **Estomac : ulcère, gastrite** : brûlure épigastrique, profonde, soulagement de la douleur après le repas (lait) et par les anti-acides
 - **Pancréas, foie, VB : cholécystite** : profonde, hypochondre, survient ap. repas

- *Autre*

- *Atteinte neuro* : douleur en ceinture, hémi-ceinture +/- trouble de la sensibilité
- *Thyroïdite* : douleur persistante, région du cou, aggravée en avalant, palpation de la thyroïde douloureuse → faire VS et TSH
- *Atteinte pariétale* : douleur de longue durée superficielles fluctuantes, douleur mécanique (exacerbées par une position ou un mouvement), reproductible à la palpation
 - *Syndrome chondrocostal* : cartilages chondrocostaux hauts ou costosternaux, pas de tuméfaction
 - *Syndrome de Tietze* : tuméfaction de la jonction costosternale, sternoclaviculaire ou chondrocostal (2^{ème} – 3^{ème} côte) *rare*
 - *Syndrome pectobrachial* : développé couché, travail sur un ordinateur, manœuvre du coq →
 - *Syndrome sternal* : douleur sur le sternum avec souvent une extension latérale de la douleur
 - *Syndrome xiphoïdien* : douleurs sur l'apophyse xiphoïdienne
 - *Douleurs costales basses* : hooking maneuver →
- *Cutané (zona)*
- *Douleur thoracique psychogène* : punctiforme, brève, augmente en inspiration, calmée couché



SE RENDRE À L'HÔPITAL (EP, infarctus, pneumothorax)

Les pièges : il peut s'agir d'un syndrome coronarien aigu, même si le patient présente :

- Une douleur épigastrique
- Une douleur dorsale
- Une brûlure thoracique
- Une irradiation vers l'épaule droite
- Une absence de douleur (surtout s'il est diabétique)
- Un ECG normal
- Une absence de soulagement par un dérivé nitré

Dyspnée

Anamnèse

1. Caractériser la dyspnée
 - a. Qualité
 - b. Depuis quand ?
 - c. Condition de survenue
 - d. Permanente / intermittente
 - e. **Nocturne / diurne** (dyspnée paroxystique nocturne = IC)
 - f. Aggravation / diminution
 - g. Facteurs favorisants
 - i. Position
 - ii. Froid
 - iii. Poussière, pollen, animaux
 - iv. Effort
 - h. Classification (périmètre de marche, nb étage etc)
2. Symptômes associés
 - a. Doul. thoraciques (caractériser si +)(oppressives → card, respiro-dép → pulm)
 - b. Toux
 - i. Depuis quand
 - ii. Fréquence
 - iii. Qualité (sèche, grasse)
 - iv. Expectoration : couleur – sang
 - c. Hémoptysie
 - d. Œdèmes MI – douleur MI
 - e. Orthopnée – dyspnée paroxystique nocturne
 - f. Nycturie
 - g. **Palpitation**
 - h. Fièvre
 - i. ORL : dysphonie – obstruction nasale
3. Symptômes B
 - a. Sudations nocturnes
 - b. Perte de poids
4. ATCD et comorbidités
 - a. Maladie
 - b. Hospitalisations
 - c. Opération (récente ?)
 - d. Médicaments (hormonothérapie)
 - e. Allergies
5. ATCD familiaux
6. **Voyage – immobilisation**
7. Habitudes
 - a. Tabac
 - b. Alcool
 - c. Drogue
 - d. Diète
 - e. Activité physique

Signes d'alarmes :

- Diminution de l'état de conscience, agitation, confusion
- Difficultés à parler (mots isolés)
- Détresse respiratoire : utilisation des muscles accessoires, tirage intercostal
- FR < 8/min ou > 25/min
- Saturation < 90%
- Cyanose
- Diaphorèse
- Arythmie nouvelle
- Fréquence cardiaque > 120/min
- TA < 90/60 mmHg (nouvelle)
- PF < 50% du prédict ou < 200 L/min

Examen clinique

1. Inspection
 - a. Extrémités (ongles)
 - b. Langue
 - c. Recoloration capillaire
 - d. Thorax et mouvements
 - e. **Oedèmes des MI (godet)**
 - f. Turgescence jugulaire
 - i. Reflux hépato-jugulaire (> 10s)
2. Cardiaque
 - a. Palpation
 - i. Pouls périphériques aux 4 extrémités
 - ii. Carotidien (**!!! auscultation avant**)
 - iii. Choc de pointe
 - b. Auscultation
 - i. Aortique
 - ii. Pulmonaire
 - iii. Mitral
 - iv. Tricuspidé
3. Pulmonaire
 - a. Palpation
 - i. Zone douloureuse (reproductible à la palpation ?)
 - ii. Ampliation thoracique (post)
 - b. Percussion (post + lat)
 - i. Délimiter
 - ii. Comparer les deux côtés
 - c. Auscultation
 - i. Antérieure
 - ii. Postérieure : 4 plages en comparant
 - iii. Latérales : 2 plages

Bruits respiratoires : (<https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMra1302901>)

- Râles crépitants fins : fibrose pulmonaire, pneumonie, stase cardiaque
- Râles crépitants grossiers : sécrétions bronchiques (bronchiectasie, bronchite)
- Ronchi : asthme, BPCO
- Sibilances : asthme, BPCO, insuffisance cardiaque
- Stridor : sténose des voies respiratoires centrales

DD

- **Aigu (< 3 semaines)**
 - *Origine cardiaque*
 - *Cardiopathie ischémique aiguë*
 - *Décompensation insuff. cardiaque (ischémique, valvulaire, rythmique)*
 - *Tamponnade*
 - *Origine respiratoire*
 - *Asthme*
 - *BPCO décompensé*
 - *EP*
 - *Pneumothorax*
 - *Pneumonie*
 - *Obstruction VA (corps étranger, anaphylaxie)*
 - *Autres*
 - *Toxiques*
 - *Métaboliques*
 - *Psychogène*
- **Chronique**
 - *Origine cardiaque*
 - *Insuffisance cardiaque (ischémique, valvulaire, rythmique)*
 - *Origine respiratoire*
 - *BPCO*
 - *Asthme*
 - *Maladie interstitielle (fibrose)*
 - *Hypertension pulmonaire (dû à cirrhose, ou post EP, ...)*
 - *Patho. extra-pulmonaire (squel, obésité, mal. pleurale, neuro-musc)*
 - *Cancer*
 - *Origine métabolique / neurologique*
 - *Acidose métabolique*
 - *Insuffisance rénale*
 - *Acidose d'origine médicamenteuse*
 - *Diabète décompensé*
 - *Myopathies*
 - *Déconditionnement*

	Mouvements thoraciques	Fremitus	percussion	auscultation	Forme thoracique	particularités
Pneumothorax	diminués du côté atteint	diminué	tympanique	hypoventilation localisée	normale	
Syndrome obstructif	diminués des 2 côtés	diminué	normale ou tympanique	hypoventilation diffuse sibilances	thorax en tonneau	respiration lèvres pincées
Origine cardiaque	normaux	normal ou augmenté	normale ou matité	sibilances, râles crépitants, hypoventilation diffuse	normal	turgescence jugulaire, souffle cardiaque, OMI symétriques
Pneumonie	normaux ou diminués du côté atteint	augmenté	matité	souffle tubaire, râles crépitants	normal	
Epanchement pleural	diminués du côté atteint	diminué	matité	hypoventilation localisée	normal	
Obstruction des VAS	augmentés	normal	normale	stridor	normal	tirage inspiratoire

Examen complémentaire possibles :

- Rx thorax
- ECG
- Gazométrie si dyspnée aiguë
- Laboratoire
 - FSC
 - Fonction rénale
 - D-dimères
 - BNP / pro-BNP
 - Troponine
- Fonction pulmonaire
- Échocardiographie / ergométrie +/- spirométrie
- Imagerie : CT-scan, scintigraphie pulmonaire

Des taux normaux permettent d'exclure la maladie/l'origine de la dyspnée

Critères d'hospitalisation

- Asthme :
 - Patient à haut risque selon les ATCD
 - Entourage ne garantissant pas une réaction adéquate en cas d'évolution défavorable
 - Absence d'amélioration après un traitement initial
- BPCO
 - Fatigue respiratoire
 - EF > 38
 - Suspicion de foyer pulmonaire
 - OMI
 - Entourage défavorable
- Insuffisance cardiaque
 - Douleurs thoraciques
 - Comorbidités importantes
 - Souffle cardiaque nouveau
 - Entourage défavorable
- Pneumonie
 - Fièvre > 40 ou T < 35
 - Comorbidité sévère
 - Plusieurs lobes atteints
 - Épanchement pleural significatif
 - PaO₂ < 60mmHg
 - pH artériel < 7.35
 - Ht < 30%
 - Na < 130 mmol/L
 - Glycémie > 14 mmol/L

DD hyperventilation – asthme :
- En faveur d'un asthme

- Sibilances
- Sécrétions
- Toux

Hémoptysie

Anamnèse

1. Caractériser l'hémoptysie
 - a. Quand tousser ? (!!! DD épistaxis et hématomèse)
 - b. Début
 - c. Fréquence
 - d. Quantité (un peu dans sang dans mouchoir ? rempli un verre ?)
2. Symptômes associés
 - a. Dyspnée
 - b. Douleurs thoraciques
 - c. Toux
 - i. Depuis quand
 - ii. Fréquence
 - iii. Qualité (sèche, grasse)
 - iv. Expectoration
 1. Couleur
 2. Sang
 - d. Oedèmes MI
 - e. Palpitation
 - f. Fièvre
3. ATCD et comorbidités
 - a. Maladie
 - b. Hospitalisations
 - c. Opération (récente ?)
 - d. Médicaments
 - e. Allergies
4. ATCD familiaux
5. Habitudes
 - a. Tabac
 - b. Diète
 - c. Activité physique

Examen clinique

1. Inspection
 - a. Extrémités (ongles)
 - b. Langue
 - c. Recoloration capillaire
 - d. Thorax et mouvements
 - e. Œdèmes des MI (godet)
 - f. Turgescence jugulaire
 - i. Reflux hépato-jugulaire (> 10s)
2. Cardiaque
 - a. Palpation
 - i. Pouls périphériques aux 4 extrémités
 - ii. Carotidien (**!!! auscultation avant**)
 - iii. Choc de pointe
 - b. Auscultation
 - i. Aortique
 - ii. Pulmonaire
 - iii. Mitral
 - iv. Tricuspide
 - v. Recherche souffle abdominal
 - vi. Recherche souffles fémoraux
3. Pulmonaire
 - a. Palpation
 - i. Zone douloureuse (reproductible à la palpation ?)
 - ii. Ampliation thoracique (post)
 - b. Percussion (post + lat)
 - i. Délimiter
 - ii. Comparer les deux côtés
 - c. Auscultation
 - i. Postérieure : 4 plages en comparant
 - ii. LatéraleS : 2 plages

DD

- **Cancer pulmonaire**
- *Bronchectasie*
- **Pneumonie**
- **Tuberculose**
- *Bronchite aiguë*
- **Embolie pulmonaire**

Palpitation

Anamnèse

1. Caractériser les palpitations
 - a. **Localisation** (cou)
 - b. Qualité
 - i. **Bat très vite**
 - ii. **Fort mais lent**
 - iii. **Régulier/irrégulier**
 - c. Facteurs aggravants / soulageants
 - d. Chronologie
 - i. Depuis quand
 - ii. **Début brusque ?**
 - iii. Évolution
 - iv. Condition de survenues
 1. Repos / effort
2. Symptômes associés
 - a. **Douleurs thoraciques**
 - b. **Dyspnée**
 - i. Condition de survenue
 - ii. Classification (périmètre de marche, nb étage etc)
 - iii. Chronologie
 - c. Toux
 - i. Depuis quand
 - ii. Fréquence
 - iii. Qualité (sèche, grasse)
 - iv. Expectoration
 1. Couleur
 2. Sang
 - d. Œdèmes des membres inférieurs
 - e. Orthopnée
3. **Syncope**
4. ATCD et comorbidités
 - a. Maladie
 - b. Hospitalisations
 - c. Opération (récente ?)
 - d. Médicaments
 - e. Allergies
5. ATCD familiaux

Examen clinique

1. Inspection
 - a. Extrémités (ongles)
 - b. Langue
 - c. Recoloration capillaire
 - d. Thorax et mouvements
 - e. Oedèmes des MI (godet)
 - f. Turgescence jugulaire
 - i. Reflux hépato-jugulaire (> 10s)
2. Cardiaque
 - a. Palpation
 - i. Pouls périphériques aux 4 extrémités
 - ii. Carotidien (**!!! auscultation avant**)
 - iii. Choc de pointe
 - b. Auscultation
 - i. Aortique
 - ii. Pulmonaire
 - iii. Mitral
 - iv. Tricuspidé
 - v. Recherche souffle abdominal
 - vi. Recherche souffles fémoraux
3. Pulmonaire
 - a. Palpation
 - i. Zone douloureuse (reproductible à la palpation ?)
 - ii. Ampliation thoracique (post)
 - b. Percussion (post + lat)
 - i. Délimiter
 - ii. Comparer les deux côtés
 - c. Auscultation
 - i. Postérieure : 4 plages en comparant
 - ii. Latérales : 2 plages

Prise en charge

- Faire ECG

DD

- *Bradyarythmies (palpitation lente)*
- *Fibrillation auriculaire (AVC, signes IC)*
- *Flutter auriculaire (AVC, signes IC)*
- *Tachycardie auriculaire (signes IC)*
- *Tachycardie supraventriculaire par réentrée nodale (cou, début et fin brusque)*
- *Tachycardie ventriculaire (FC : 150-200 mais hypotension)*

Syncope

1. Caractériser la syncope
 - a. **1^{er} épisode ?**
 - b. **Durée de la perte de connaissance**
 - c. **Trauma crânien ?**
 - d. **Prodromes**
 - i. Diaphorèse
 - ii. Vertiges
 - iii. Voile noir
 - iv. Phosphènes (tâches lumineuses devant les yeux)
 - v. Palpitation
 - e. **Condition de survenue**
 - i. En se levant
 - ii. Debout depuis longtemps
 - iii. Facteurs de stress
 - f. **Pendant la crise**
 - i. Mouvements anormaux
 - ii. Convulsion
 - iii. Yeux ouverts ou fermés
 - iv. Morsure de la langue
 1. Antérieure
 2. Latérale
 - g. **Perte d'urine → épilepsie**
 - h. **État post critique**
 - i. Repris ses esprits
 - i. **2^{ème} crise successive**
2. Symptômes associés
 - a. Perte de poids
 - b. Fatigue
 - c. Sudations nocturnes
 - d. Fièvre
 - e. Nausée
3. Anamnèse par système
 - a. Cardiaque
 - i. **Douleurs thoraciques**
 - ii. **Peine à respirer : dyspnée**
 - iii. À l'effort
 1. Palpitation
 2. Dyspnée
 3. Angor
4. ATCD
 - a. Maladie - hospitalisation
 - b. Opération
 - c. Médicaments
5. ATCD familiaux
6. Habitudes

Examen clinique

1. Inspection
 - a. Extrémités (ongles)
 - b. Langue
 - c. Conjonctive
 - d. Recoloration capillaire
 - e. Thorax et mouvements
 - f. Oedèmes des MI (godet)
 - g. Turgescence jugulaire
 - i. Reflux hépato-jugulaire (> 10s)
2. Cardiaque
 - a. Palpation
 - i. Pouls périphériques aux 4 extrémités
 - ii. Carotidien (**!!! auscultation avant**)
 - iii. Choc de pointe
 - b. Auscultation
 - i. Aortique
 - ii. Pulmonaire
 - iii. Mitral
 - iv. Tricuspe
3. Pulmonaire
 - a. Palpation
 - i. Zone douloureuse (reproductible à la palpation ?)
 - ii. Ampliation thoracique (post)
 - b. Percussion (post + lat)
 - i. Délimiter
 - ii. Comparer les deux côtés
 - c. Auscultation
 - i. Postérieure : 4 plages en comparant
 - ii. Latérales : 2 plages

Signes d'alarmes :

- > 60 ans
- ATCD coronariens
- FRCV
- **Valvulopathie connue ou souffle cardiaque**
- Signes de choc
- Circonstances
 - Pendant un effort physique
- Prodromes
 - Aucun
 - **Palpitations**
 - **Douleurs thoraciques**
 - Céphalées
 - **Douleurs abdominales chez la femme ou la personne âgée**

- Récupération
 - Dyspnée
 - **Manifestations neurologiques focales**
 - Hémorragie digestive
 - Douleur thoracique
 - Tachycardie

DD :

- **Cardiaques**
 - *Troubles du rythme (palpitation)*
 - *Bradycardie*
 - *Tachycardie*
 - *Maladie organique*
 - *Sténose aortique*
 - *Cardiomyopathie obstructive*
 - *Embolie pulmonaire*
 - *Infarctus*
 - *Tamponnade*
 - *HTAP*
 - *Dissection aortique*
- *Non cardiaque*
 - *Neurogène*
 - **Vaso-vagale** (*stress, prodrome positif, pas d'état post-critique*)
 - *De situation*
 - *Syndrome du sinus carotidien*
 - **Hypotension orthostatique** (*en se levant*)
 - *Maladies neurologiques*
 - **Crise d'épilepsie** (*yeux ouverts, mouvements pendant crise, perte d'urine, état post-critique, morsure langue latérale*)
 - **Crise psychogène non épileptique** (*yeux fermés*)
 - *Choc*
 - *Médicaments*
 - *Psychiatriques*

Toux

Anamnèse

1. Toux
 - a. Depuis quand
 - b. Fréquence
 - c. Qualité (sèche, grasse, rauque)
 - d. Expectoration
 - i. Couleur
 - ii. Sang
 - e. Condition de survenues
 - i. Effort (*asthme, IC*)
 - ii. Nuit (*asthme, IC*)
 - iii. Lever (*RGO*)
 - iv. Matin (*bronchite chronique, rhinorrhée post*)
 - v. Changement de position (*pathologie pleurale*)
 - vi. Déglutition (*fausse route*)
2. Symptômes associés
 - a. Dyspnée
 - i. Condition de survenue
 - ii. Classification (périmètre de marche, nb étage etc)
 - iii. Chronologie
 - b. Douleurs thoraciques
 - c. Hémoptysie
 - d. Oedèmes des membres inférieurs
 - e. Orthopnée
 - f. Palpitation
 - g. **Fièvre** (check comptage infectieux)
3. ATCD et comorbidités
 - a. Maladie
 - b. Hospitalisations
 - c. Opération (récente ?)
 - d. Médicaments
 - e. Allergies
4. Facteurs de risques
 - a. Tabagisme
5. ATCD familiaux

Examen clinique

1. Inspection
 - a. Extrémités (ongles) + langue
 - b. Recoloration capillaire
 - c. Thorax et mouvements
 - d. Oedèmes des MI (godet)
 - e. Turgescence jugulaire + reflux hépato-jugulaire (> 10s)
2. Cardiaque
 - a. Palpation
 - i. Pouls périphériques aux 4 extrémités
 - ii. Carotidien (**!!! auscultation avant**)
 - iii. Choc de pointe
 - b. Auscultation
 - i. Aortique
 - ii. Pulmonaire
 - iii. Mitral
 - iv. Tricuspile
3. Pulmonaire
 - a. Palpation
 - i. Zone douloureuse (reproductible à la palpation ?)
 - ii. Ampliation thoracique (post)
 - b. Percussion (post + lat)
 - i. Délimiter
 - ii. Comparer les deux côtés
 - c. Auscultation
 - i. Antérieure
 - ii. Postérieure : 4 plages en comparant
 - iii. Latérales : 2 plages

DD

Aiguë (< 3 semaines)

- *Infection des voies aériennes supérieures*
- *Asthme*
- *Exacerbation BPCO*
- *Corps étranger*
- *Pneumonie*

3 – 8 semaines

- *Toux post infectieuse (dû à irritation)*
- *Coqueluche*

Chronique (> 8 semaines)

- *Syndrome de toux d'origine des voies aériennes supérieures – rhinorrhée post*
- *Asthme*
- *BPCO*
- *RGO*
- *Médicamenteuse : IEC*
- *Pneumopathie interstitielle*
- *Cancer broncho-pulmonaire*
- *Insuffisance cardiaque*

Fatigue

Anamnèse

1. Caractérisation de la fatigue
 - a. Apparition – début
 - b. Évolution – fluctuence
 - c. Intensité → impact sur AVQ, impact de l'activité physique et mentale
 - d. Moment de la journée
 - e. Premier épisode
2. Caractérisation du sommeil
 - a. Durée du sommeil (heure de coucher et de lever) (semaine vs weekend)
 - b. Qualité du sommeil (**reposé au réveil ?**)
 - c. Réveils durant la nuit
 - d. Habitude avant de dormir – utilisation des **écrans**
3. Habitudes
 - a. Diète – alimentation : plats types, grignotage
 - b. Alcool – drogue
 - c. **Médicament**
4. **DD dépression**
 - a. Perte de plaisir, manque d'intérêt
 - b. Tristesse, idées noires, envie suicidaire
5. **DD cancer**
 - a. Perte de poids
 - b. Fièvre, sudation nocturne
6. **DD maladie infectieuse (EBV, CMV, VIH, Hépatite, Tuberculose, Endocardite)**
 - a. Douleurs abdominales (+ *Ca colon, maladie coeliaque, MICI, intoxication*)
 - b. Rapports sexuels à risque
 - c. Voyage
 - d. Fièvre
7. **DD cardiovasculaire**
 - a. Dyspnée, orthopnée paroxystique nocturne
 - b. Toux (sèche)
 - c. Jambes gonflées
8. **DD SAOS**
 - a. Somnolence diurne
 - b. Ronflement
 - c. Céphalées matinales
9. **DD hypothyroïdie**
 - a. Prise de poids
 - b. Froid
10. **DD anémie ferriprive**
 - a. Ménométrorragie, sang dans les selles, méléna
11. **DD diabète, hyperparathyroïdie**
 - a. Polyurie, polydipsie
12. **DD connectivites (Ehlers-Danlos)**
 - a. Arthralgies, hyperlaxité articulaire
13. **DD Myopathies, myasthénie, SEP, Parkinson**
 - a. Faiblesse musculaire

Examen clinique

- Palpation de la thyroïde (faire ROT achilléen)
- Palpation des aires ganglionnaires
 - Cervicales
 - Axillaires
 - Inguinales
- Palpation et percussion des loges rénales
- Status cardiaque
 - Inspection (cyanose, oedème)
 - Auscultation de la carotide
 - Palpation du choc de pointe
 - Auscultation des aires cardiaques
- Si arthralgies ou hyperlaxité → check
- Si faiblesse musculaire → check Babinski (SEP)

Examen complémentaire

Laboratoire :

- **FSC, VS**
- **TSH**
- ALAT – ASAT
- **Ferritine**
- **Test de grossesse**
- Autre selon contexte
 - Bilan infectieux :
 - Elispot-Tbc
 - Test HIV
 - Sérologie hépatites
 - Si originaire d'Amérique latine : maladie de Chagas
 - Si originaire zone endémique malaria + anémie ou fièvre : malaria
 - Glycémie, électrolytes
 - Calcium
 - Phosphatase alcaline
 - Créatinine, CK
 - Bandelette urinaire
 - Electrophorèse des protéines
 - Auto-anticorps (**anti-transglutaminases → maladie coeliaque**)
 - Rx du thorax
 - **Mammographie, colonoscopie**

DD

- *Dépression, burn out*
- **Cancer**
- **Maladie coeliaque**, MICI
- *Maladie infectieuse* (EBV, CMV, VIH, Hépatite, Tuberculose, Endocardite, Covid)
- *Cardiovasculaire* : **insuffisance cardiaque**
- *Hématologique* : **anémie**
- **SAOS**
- **Origine endocrinienne**
 - **Diabète**
 - **Hypothyroïdie**
 - **Hypercalcémie** (hyperparathyroïdie)
 - **Insuffisance corticosurrénalienne - Maladie d'Addison** (test au synacthen)
 - *Insuffisance corticosurrénalienne primaire*
 - *Destruction auto-immune*
 - *Infection* (HIV, fongique, CMV, tuberculose, parasite, syphilis)
 - *Infarctus hémorragique*
 - *Métastases bilatérales*
 - *Médicamenteux*
 - *Inhibiteur de la synthèse du cortisol*
 - *Aminoglutéthimide*
 - *Ketoconazole*
 - *Fluconazole*
 - *Etomidate*
 - *Inducteur du catabolisme du cortisol*
 - *Phenobarbital – phénytoïne*
 - *Rifampicine*
 - *Insuffisance corticosurrénalienne secondaire*
 - *Hypopituitarisme*
 - **Sevrage suite à glucocorticoïdes exogènes**
 - **Hypogonadisme (stéroïdes exogènes)**
- *Connectivites* (Ehlers-Danlos)
- *Médicament* (somnifères, anti-hypertenseurs, anti-dépresseurs)

DD hypercalcémie :

- *Asthénie*
- *Troubles de la concentration*
- *Douleurs ostéo-articulaires*
- *Soif, polyurie, polydypsie*
- *Lithiase rénale*
- *Nausée, constipation, anorexie*

DD insuffisance surrénalienne :

- Symptômes
 - Fatigue
 - **Perte pondérale**, dysgueusie, anorexie
 - Myalgies, arthralgies
 - Douleurs abdominales
 - Peau sèche, prurit
 - Altération de la libido
 - Vertiges
- Signes
 - Hypotension orthostatique
 - Pâleur (ICS secondaire) vs bronzage (ICS primaire)
 - Anémie, lymphocytose, éosinophilie
 - Hyperkaliémie – hyponatrémie
 - EF
 - Hypercalcémie

DD hypothyroïdie :

- Symptômes et signes
 - **Fatigue**
 - **Froid**
 - **Prise pondérale**
 - Perte du tiers externe des sourcils
 - Constipation
 - Troubles du cycle
 - Trouble de la mémoire
 - Myxoedème
 - **Alopécie**
 - Macroglossie
 - SAOS
 - Tunnel carpien
- Laboratoire
 - **Dyslipidémie**
 - CK élevés
 - Anémie macrocytaire
 - Hyponatrémie

Fatigue

1. AA

- durée sommeil
- hygiène
- ronflements
- réveils nocturnes/étouffements
- apnée remarquée par conjoint
- stress/ED
- changement d'habitude
- travail nocturne
- régime
- changement de poids
- symptômes thyroïdiens
- anémie/antécédents d'hémorragie
- traitement habituel
- OH/caféine/drogues

2. Status

- signes vitaux
- ORL (conjonctives pâles, LA, thyroïde)
- examen cardio-pulmonaire
- examen neurologique
- extrémités (pâleur, froideur)
- TR/test de sang occulte

3. DD

- ED
- PTSD
- cancer du côlon
- hypothyroïdie
- SAOS
- DM
- trouble du sommeil en lien avec travail nocturne

Douleurs abdominales

Anamnèse

1. Caractérisation de la douleur
 - a. Localisation
 - b. Irradiation
 - c. Chronologie
 - i. Début
 - ii. Circonstance de survenue
 - iii. Évolution (fluctuation)
 - d. Intensité
 - e. Qualité
 - f. Facteurs aggravants/soulageants
2. Symptômes associés
 - a. **Fièvre**
 - i. Début
 - ii. Intensité
 - iii. Fluctuation
 - b. **Frissons**, transpiration
 - c. **Perte de poids**, modification de l'appétit
 - d. Fatigue
 - e. Ictère
 - f. Vertige
3. Système digestif
 - a. Manger, boire ?
 - b. Nausée, vomissement
 - c. Selles
 - i. Consistance
 - ii. Fréquence, quantité
 - iii. Couleur
 - iv. Sang
 - v. Flottent – glaires
 - vi. **Dernières selles / derniers gaz**
4. Système urogénital
 - a. Douleur à la miction
 - b. Fréquence mictionnelle, quantité
 - c. Couleur
 - d. Sang dans l'urine
 - e. **Dernières règles si femme**
 - f. **Possibilité d'être enceinte ?**
 - g. **Perte vaginale si femme**
5. Antécédent
 - a. **Épisode similaire antérieur ?**
 - b. Maladie
 - c. Hospitalisation/opération
 - d. Médicaments
 - e. Allergie

Schmerztyp	Diagnose			
				
Perforation	Ulcusperforation	Mesenterialinfarkt	Gallenblasenperforation	
				
Kolik	Gallenkolik	Uretersteinkolik	Ileus	
				
Entzündung	Appendizitis	Pankreatitis	Cholezystitis	

Anamnèse gynécologique

6. Habitudes
 - a. Diète (contenu du dernier repas)
 - b. Alcool
 - c. Tabac
 - d. Drogues

Signes d'alarmes :

- État de choc
- Agitation, torpeur, conscience altérée
- Masse abdominale pulsatile
- État fébrile
- Ictère
- Déshydratation, oligo-anurie
- Dyspnée/tachypnée
- Rectorragies, méléna
- Âge > 65 ans
- Retard de règles
- Traumatisme récent

Examen clinique

1. Installation
 - a. **Bras et jambes décroisées**
 - b. Tête légèrement surélevée
 - c. Abdomen entièrement visible
2. Inspection
 - a. Visage : malaise, douleur
 - b. Peau : cicatrices, veines dilatées, lésions cutanées, vergetures...
 - c. Allure de l'abdomen : plat, arrondi, symétrie, voussure
 - d. Mouvements : respiratoire, péristaltique, pulsatiles
3. Auscultation (**avant palpation**)
 - a. 4 quadrants (fréquence gargouilles : 5-34/min)
 - b. Aorte
 - c. A. iliaque
4. Percussion
 - a. 4 quadrants
 - b. Délimite la taille du foie
5. Palpation (+ check visage patient, si résistance, le faire en expiration et en respirant par la bouche ouverte, mâchoire tombante)
 - a. 4 quadrants
 - i. Superficielle (1 main)
 - ii. Profonde (2 mains)
 - iii. Détente et défense
 - b. Palpation du foie
 - c. Palpation de la rate
 - d. Palpation des reins
 - e. Aorte (anévrisme)
 - f. Orifice herniaire

6. Tests spécifiques
 - a. Mc Burney
 - b. Signes du psoas
 - c. Signe de Murphy
7. Percussion des reins
8. **EVOQUER UN TOUCHER RECTAL + PALPATION AILES INGUINALES**

Examen complémentaire

- Fièvre, frisson → prise de sang
 - > 38.5 → hémoculture
- Hypochondre droit → ASAT, ALAT, gamma GT, phosphatase alcaline, bilirubine, albumine, TP/INR, marqueur inflammatoire, lipase
- Imagerie (CT, Rx, US...)
 - US :
 - Liquide libre abdominal
 - Anévrisme de l'aorte
 - Grossesse extra-utérine
 - Pathologie hépato-biliaire
 - Globe vésical, dilatation pyélo-calicienne
 - Appendicite
- Douleur épigastrique → ECG
- Hospitalisation ? antibiotique ? **antalgie** ?
- Coloscopie si
 - > 50 ans et douleur abdo
 - Bilan diarrhée
 - Bilan anémie

DD

- Douleur hypochondre droite
 - **Cholangite** (fièvre, douleur : murphy +, ictère)
 - **Angiocholite** (fièvre 39.5, frissons, ictère, secondairement à obstruction des voies biliaires)
 - **Hépatites aiguës** (ictère, douleur hypochondre D)
 - **Cholecystite** (si murphy +, pas d'ictère, crampiforme, fièvre)
 - **Cholédocholithiase** (douleur < 6h, pas de fièvre, déclenché par repas copieux, graisse, alcool, nausée vomissement, ictère, selles décolorées – urines foncées, pancréatite biliaire)
 - **Pancréatite** (douleur transfixiante)
 - **Abcès hépatiques**
 - **Thrombose veineuse**
 - **Insuffisance cardiaque droite** (nausée, vomissement, inappétence, hépatomégalie, constipation)
 - **Pneumonie** (souvent avec symptômes respiratoires, mais aussi nausée, vomissement)
 - **Pyélonéphrite**
- DD douleur hypochondre gauche
 - **Infarctus splénique**
 - **Abcès splénique**

- *Rupture splénique (rechercher traumatisme)*
- *Splénomégalie (chronique)*
- *Pneumonie (souvent avec symptômes respiratoires, mais aussi nausée, vomissement)*
- *Pyélonéphrite*
- DD douleur épigastrique et/ou périombilicale
 - **Infarctus du myocarde inférieur** (parfois vomissement, nausée)
 - **Dissection aortique** (douleur brutale en coup de couteau, transfixiante, douleur dans les jambes, souffle aortique diastolique)
 - **Pancréatite aiguë** (fièvre, douleur transfixiante, position en chien de fusil, iléus)
 - **Pancréatite chronique** (douleurs transfixiante, épisodes à répétition, intensité augmente, ictère, insuffisance exocrine : diarrhées - selles avec glaires, insuffisance endocrine : diabète)
 - **Ulcère gastrique** (douleur indépendante des repas, méléna, hématémèse, anémie, FR : alcool tabac, stress)
 - **Ulcère gastroduodénal** (amélioré par repas, douleur à jeun, méléna, hématémèse, anémie FR : stress, alcool, tabac)
 - **Gastrite** (fièvre, nausée-vomissement, satiété précoce)
 - **RGO** (brûlures épigastriques, régurgitation, nausée, satiété précoce, éructation, toux chronique)
- DD douleur au flanc
 - **Origine uro-génitale :**
 - **Colique néphrétique** (lithiase rénale : douleur au flanc qui irradie dans organes génitaux externes, coup de couteau, subite, diminué par l'application de chaud et par antalgique)
 - **Pyélonéphrite aiguë** (CT si pyélo compliquée)
 - Infarctus ou hématome rénal
 - Toute pathologie obstructive rénale
 - **Torsion testiculaire**
 - **Torsion ovarienne** (FR ovaire polykystique : pilosité augmentée, obésité, stérilité, acné)
 - Kyste ovarien
 - **Endométriose**
 - **Grossesse extra-utérine**
 - **Origine digestive :**
 - **Iléus** (ATCD chir abdo, pas de selles depuis qq jours, ni gaz, vomissement, miserere, pas de bruit = paralytique vs bruit métallique = mécanique)
 - **Maladie inflammatoire du tube digestif**
 - **Diverticulite**
 - **Origine vasculaire :**
 - Dissection aortique
 - Anévrisme
- DD douleur fosse iliaque
 - **Appendicite à droite** (para-ombilicale, secondairement en FID, rapidement croissante, vomissement, signe du psoas, Mc Burney)
 - **Diverticulite** (G >> D, péritonisme, fièvre)

- **Maladie de Crohn** (diarrhée chronique > 30j, perte de poids, sudation nocturne, sang dans les selles)
- **Colite ulcéreuse** (diarrhée chronique > 30j, perte de poids, sudation nocturne, sang dans les selles → réctorragies, ténésme, urgence, lithiase vésiculaire)
- *Iléite terminale*
- *Colite*
- *Affections gynécologiques*
- *Hématome du psoas (baisse TA)*
- DD douleur sus pubienne
 - *Cystite*
 - *Globe vésical (matité à la percussion, douleur à la palpation)*
 - **Affection gynécologique**

Autre

- *Colite infectieuse (anamnèse d'exposition = voyage, ballonnement, diarrhées glairo-sanglantes, perte de poids, fièvre)*
- *Côlon irritable (un jour par semaine durant les 3 derniers mois, douleur soulagée suite à selles, modification fréquence et consistance)*

Urgence

- **Péritonite** (< perf, ventre de bois, silence auscultatoire, fièvre)
 - CT + avis chir
- **Ischémie mésentérique** (empiré par repas, diarrhée glairo-sanglante, fièvre)
 - CT + avis chir
- **Occlusion** (abdo douloureux dans son ensemble, tympanisme, bruit métallique)
 - CT + avis chir
- **Rupture AA** (FR : homme, âge, tabac, HTA, douleur subite, irradiation dans le dos, état de choc)
 - US si instable ou CT si stable + avis chir
- **Grossesse extra-utérine** (amnénorrhée, douleurs abdo intenses, métrorragies)
 - Test de grossesse + US endovaginal

Douleurs abdominales aiguës : messages essentiels :

- Douleur abdominale d'origine incertaine → ECG à la recherche de SCA
- **Douleur abdominale chez une femme en âge de procréer → test de grossesse**
- Symptôme de colique néphrétique chez un patient de > 70 ans → suspecter un anévrisme de l'aorte (colique néphrétique inaugurale exceptionnelle au-delà de 70 ans)
- Signes d'alarmes : état de choc, péritonisme, ECG pathologique, traumatisme, test de grossesse + → hospitaliser le patient
- TRAITER LA DOULEUR

Dysphagie

Anamnèse

1. **Caractérisation de la dysphagie**
 - a. **Chronologie**
 - i. **Début**
 - ii. **Circonstance de survenue**
 1. **Solide**
 2. **Liquide**
 - iii. **Évolution (fluctuation)**
 - b. **Facteurs aggravants/soulageants (pire en fin de journée)**
2. **Symptômes associés**
 - a. **Régurgitation, reflux**
 - b. Douleurs
 - c. Fièvre
 - i. Début
 - ii. Intensité
 - iii. Fluctuation
 - d. Frissons, transpiration
 - e. Perte de poids, modification de l'appétit
 - f. Fatigue
 - g. Ictère
 - h. Vertige
3. **Système digestif**
 - a. Manger, boire ?
 - b. Nausée, vomissement
 - c. Selles
 - i. Consistance
 - ii. Fréquence, quantité
 - iii. Couleur
 - iv. Sang
 - v. Flottent
 - vi. Dernières selles / derniers gaz
4. **Système urogénital**
 - a. Douleur à la miction
 - b. Fréquence mictionnelle, quantité
 - c. Couleur
 - d. Sang dans l'urine
 - e. Dernières règles si femme
 - f. Perte vaginale si femme
5. **Antécédent**
 - a. Épisode similaire antérieur ? **ATCD de blocage alimentaire ?**
 - b. Maladie
 - c. Hospitalisation/opération
 - d. Médicaments
 - e. **Allergie (si oui surement dysphagie à éosinophile)**

6. Habitudes
 - a. Diète
 - i. Contenu du dernier repas
 - b. Alcool
 - c. Tabac
 - d. Drogues

Examen clinique

1. Installation
 - a. Bras et jambes décroisées
 - b. Tête légèrement surélevée
 - c. Abdomen entièrement visible
 - d. Se place à droite du patient
2. Inspection
 - a. Visage : malaise, douleur
 - b. Peau : cicatrices, veines dilatées, lésions cutanées, vergetures...
 - c. Omphalique
 - d. Allure de l'abdomen : plat, arrondi, symétrie, voussure
 - e. Mouvements : respiratoire, péristaltique, pulsatiles
3. Auscultation (**avant palpation**)
 - a. 4 quadrants (fréquence gargouilles : 5-34/min)
 - b. Aorte
 - c. A. iliaque
4. Percussion
 - a. 4 quadrants
 - b. Délimite la taille du foie
5. Palpation (+ check visage patient, si résistance, le faire en expiration et en respirant par la bouche ouverte, mâchoire tombante)
 - a. 4 quadrants
 - i. Superficielle (1 main)
 - ii. Profonde (2 mains)
 - iii. Détente et défense
 - b. Palpation du foie
 - c. Palpation de la rate
 - d. Palpation des reins
 - e. Aorte (anévrisme)
 - f. Orifice herniaire
6. Tests spécifiques
 - a. Mc Burney
 - b. Signes du psoas
 - c. Signe de Murphy
7. Percussion des reins
8. **EVOQUER UN TOUCHER RECTAL + PALPATION AIRES INGUINALES**

DD

- **Maladie des spasmes étagés** : douleurs thoraciques
- **Œsophage casse-noisette** : douleurs rétrosternales
- **Achalasie** : voyage, origine d'amérique du sud → Chagas
- **Sclérodermie** : RGO, syndrome de Raynaud, sclérodactylie, télangiectasie, calcinose sous-cutanée
- **Oesophagie à éosinophile** : douleur thoracique, autres allergies, blocage alimentaire, DD : gastroscopie
- **Myasthénia gravis** (atteinte bulbaire et musculaire de l'œsophage) : faiblesse fluctuante des muscles, faiblesse des membres proximaux, diplopie et/ou ptose, symptômes bulbaires : dysphagie, mastication fatigable, régurgitation nasale
- **SLA**
- **Cancer de l'œsophage**
- **Diverticule de Zenkel** : foetor, régurgitation, douleur retrosternale

Ictère

Anamnèse

1. Caractériser l'ictère
 - a. Début
 - b. Contexte d'apparition
 - c. Localisation
 - d. Facteurs aggravants
 - e. Facteurs atténuants
 - f. Constant vs fluctuant
 - g. Symptômes associés
 - h. 1^{er} épisode vs récurrent**
2. Anamnèse générale
 - a. Perte de poids
 - b. Fièvre
 - c. Frissons
 - d. Sudations nocturnes
3. Anamnèse digestive
 - a. Douleur abdominale (caractériser si oui)
 - b. Nausée et vomissement
 - c. Dysphagie
 - d. Selles
 - i. Fréquence
 - ii. Sang
 - iii. Couleur**
4. **DD hépatites**
 - a. Vaccin hépatite A et B**
 - b. Voyage dans les zones endémiques**
 - c. Drogues IV**
 - d. Rapports sexuels à risque**
 - e. Tatouage récent, piercing**
5. Anamnèse urogénitale
 - a. Couleur des urines**
 - b. Sang dans les urines
 - c. Dernières règles
6. Antécédents personnels
 - a. Maladie
 - b. Médicaments
 - c. Chirurgie
 - d. Hospitalisation
 - e. Allergies
7. Antécédents familiaux
8. Habitudes alimentaires

Examen clinique

1. Préparation du status
 - a. Position de l'étudiant à D
 - b. Jambes et bras décroisés, le long du corps
 - c. Tête du patient surélevée
2. Regarder les sclères
3. Auscultation (**avant palpation**)
 - a. 4 quadrants
4. Percussion
 - a. 4 quadrants
 - b. Délimité la taille du foie
5. Palpation des (**!!! maintenir contact visuel**)
 - a. Superficiel
 - i. 4 quadrants
 - b. Palpation profonde
 - i. 4 quadrants
 - ii. Rate
 - iii. Reins
 - iv. Foie
 - c. Défense et détente
 - d. **Murphy**

DD

- **Néoplasie des voies biliaires**
- *Cholangite = inflammation que du cholédoque (fièvre, douleur : murphy +)*
- *Angiocholite = inflammation de toutes les voies biliaires (fièvre 39.5, frissons, douleur hypochondre D, secondairement à obstruction des voies biliaires)*
- **Choléchodocholithiase**
- **Hépatite** (douleur hypochondre D)
- **Pancréatite chronique** (douleurs irradiant dans le dos, épisodes à répétition, intensité augmente)
- **Carcinome pancréatique**
- **Hémolyse**
 - o *Malaria (fatigue, fièvre, hémolyse)*
 - o *Auto-immun (héماغlutinine froide, héماغlutinine chaude)*
 - o *Allo-immun (, incompatibilité ABO, rhésus)*
 - o *Thalassémie*
 - o *Déficit G6PD*

Examen complémentaire :

- CRP
- Crase
- Bilan hépatique, lipase
- LDH, haptoglobine
- Coombs si suspicion hémolyse

Bilirubine :

- *Bilirubine conjuguée : obstruction, foie*
- *Bilirubine non conjuguée : hémolyse*

Douleur aux testicules

Anamnèse :

- Caractérisation de la douleur
 - Localisation : unilatéral vs bilatéral
 - Irradiation
 - Chronologie
 - Début
 - Circonstance de survenue
 - Évolution (fluctuation)
 - Intensité
 - Qualité
 - Facteurs aggravants/soulageants
- Manifestations associées
 - Rougeur
 - Augmentation de taille
 - Masse palpée
- Antécédent
 - **ATCD testiculaires**
 - **Torsion testiculaire**
 - **Cancer testiculaire**
 - **Cryptorchidie**
 - Épisode similaire antérieur ?
 - Maladie
 - Hospitalisation/opération
 - Médicaments
 - Allergie
- ATCD familiaux
- Habitudes
 - **Rapports sexuels à risque**
 - **Activité physique : sport de combat, cycliste ?**
 - **Métier avec station assise prédominante(chauffeur)**
 - Diète
 - Alcool
 - Tabac
 - Drogues

Examen clinique :

- Status abdominal + percussion loge rénale
- Examen des OGE
 - Inspection
 - Éruption cutanée
 - Érythème
 - Hématome
 - Tuméfaction
 - Écoulement au niveau du méat
 - Palpation
 - Recherche d'une masse
 - Douleur à la palpation
 - **Signe de Prehn** = soulagement lorsque testicule soulevé (=positif)
 - Ganglions au niveau des plis inguinaux
 - Transillumination
- Examen du rachis (T12-L1)

DD :

- *Douleur scrotale aiguë < 4 semaines :*
 - *Torsion testiculaire* : douleur sévère et abrupte
 - *Torsion d'appendice testiculaire*
 - *Orchi-épididymite* : signe de Prehn positif
 - *Masse testiculaire*
 - *Trauma scrotal ou testiculaire*
- *Douleurs scrotales > 4 semaines :*
 - *Prostatite*
 - *Hernie inguino-scrotale*
 - *Varicocèle* : tuméfaction, transillumination opaque
 - *Spermatocèle*
 - *Douleur référée*
 - *Syndrome de Maigne* = douleurs référées ou projetées à distance de la colonne vertébrale (T12-L1) : lombalgie basse, douleur abdominale basse, douleur inguino-puboscrotales, douleurs de la face latérale de la cuisse en région trochantérienne
 - **Colique néphrétique**

Hydrocèle : tuméfaction, transillumination transparente
--

Douleurs en urinant

Anamnèse

1. Caractérisation de la douleur
 - a. Qualité
 - b. Intensité
 - c. Irradiation
 - d. Facteurs aggravants et soulageant
 - e. Symptômes associés
 - f. Chronologie de la douleur
 - i. Début
 - ii. Circonstance de survenue
 - iii. Évolution
2. Anamnèse urologique
 - a. Fréquence mictionnelle
 - b. Quantité d'urine
 - c. Couleur des urines
 - d. Présence de sang
 - e. Impériosité**
 - f. Nycturie**
 - g. Latence mictionnelle**
 - h. Jet saccadé**
 - i. Sensation de mal vidange vésicale**
3. Anamnèse génitale
 - a. Pertes vaginales**
 - b. Prurit vaginal
 - c. Date des dernières règles
4. **Anamnèse sexuelle** (il est fréquent que ce genre de symptôme soit associé à la sexualité, je me permets donc de vous demander...)
 - a. Pratiques (types)
 - b. Partenaires (genre, nombre)
 - c. Type de protection utilisée durant les rapports
 - i. !!! Prep protège du VIH mais pas des autres IST
 - d. Antécédent IST
 - e. Moyens contraceptifs utilisés
5. Anamnèse générale
 - a. Fièvre
 - b. Transpiration
 - c. Perte de poids involontaire
6. Antécédent personnel
 - a. Maladie comorbidités
 - b. Interventions ou hospitalisations
 - c. Allergies
 - d. Médicaments
7. Antécédents familiaux

Examen clinique

1. Installation
 - a. Bras et jambes décroisées
 - b. Tête légèrement surélevée
 - c. Abdomen entièrement visible
 - d. Se place à droite du patient
2. Inspection
 - a. Visage : malaise, douleur
 - b. Peau : cicatrices, veines dilatées, lésions cutanées, vergetures, ictères
 - c. Omphalique
 - d. Allure de l'abdomen : plat, arrondi, symétrie, voussure
 - e. Mouvements : respiratoire, péristaltique, pulsatiles
3. Auscultation (**avant palpation**)
 - a. 4 quadrants (fréquence gargouilles : 5-34/min)
 - b. Aorte
 - c. A. iliaque
4. Percussion
 - a. 4 quadrants
 - b. Délimite la taille du foie
5. Palpation (+ check visage patient, si résistance, le faire en expiration et en respirant par la bouche ouverte, mâchoire tombante)
 - a. 4 quadrants
 - i. Superficielle (1 main)
 - ii. Profonde (2 mains)
 - iii. Détente et défense
 - b. Palpation du foie
 - c. Palpation de la rate
 - d. Palpation des reins
 - e. Palpation vessie
 - f. Aorte (anévrisme)
 - g. Orifice herniaire
6. Tests spécifiques
 - a. Mc Burney
 - b. Signes du psoas
 - c. Signe de Murphy
7. Percussion des reins
8. **EVOQUER UN TOUCHER RECTAL + PALPATION AIRES INGUINALES**

DD

- **Infection urinaire basse** (cystite : pollakiurie, dysurie, femme)
- **Pyléonéphrite** (percussion rein douloureux)
- **Trouble mictionnel lié à l'hypertrophie de la prostate** (trouble mictionnel : pollakiurie, impériosité, dysurie, nycturie, latence mictionnel, jet faible, trouble de l'érection, trouble de l'éjaculation)
- **Vessie neurogène** (pollakiurie, fuites, nycturie, dysurie, latence mictionnelle, jet saccadé, sensation de mal vidange, souvent autre plainte neuro)

- **Gonorrhée** (goutte de pus - écoulement, démangeaison, dysurie, fièvre, abdomen aigu, douleur à la mobilisation du col, DD frottis chlamydia – gonorrhée, ttt : ceftriaxone + azithromycine)
- **Chlamydia** (goutte de pus - écoulement, démangeaison, dysurie, fièvre, abdomen aigu, douleur à mobilisation du col, DD frottis chlamydia – gonorrhée, ttt : doxycycline ou macrolide)
- **Mycose** (démangeaison, perte inhabituelle, douleurs lors de la miction, douleur lors des rapports sexuels, ttt : ovule)
- **Trichomonas** (démangeaison, perte vaginale purulente, douleurs lors de la miction, douleur lors des rapports sexuels, cervix érythémateux)
- **Herpès génital** (rouge, tuméfié, bulle → ulcère, ttt : acyclovir)
- **Syphilis** (chancre en aigu – ulcère sur les OGE, adénopathie, DD : prise de sang, ttt : penicilline G)

Hématurie

Anamnèse

1. Caractérisation de l'hématurie
 - a. **Couleur**
 - b. Chronologie : début
 - c. Début – milieu – fin
2. Anamnèse urologique
 - a. Présence de douleur associée ?
 - i. Qualité
 - ii. Intensité
 - iii. Irradiation
 - iv. Facteurs aggravants et soulageant
 - v. Chronologie de la douleur
 1. Début
 2. Circonstance de survenue
 3. Évolution
 - b. Fréquence mictionnelle
 - c. Quantité d'urine
 - d. **Impériosité**
 - e. **Nycturie**
 - f. **Latence mictionnelle**
 - g. **Jet saccadé**
 - h. **Sensation de mal vidange vésicale**
3. Anamnèse génitale
 - a. Pertes vaginales
 - b. Prurit vaginal
 - c. Date des dernières règles
4. Anamnèse sexuelle (il est fréquent que ce genre de symptôme soit associé à la sexualité, je me permets donc de vous demander...)
 - a. Pratique (types)
 - b. Partenaires (genre, nombre)
 - c. Protection utilisée durant les rapports
 - d. Précédent : Antécédent IST
 - e. Prévention : moyens contraceptifs utilisés
5. Anamnèse générale
 - a. Fièvre
 - b. Transpiration
 - c. Perte de poids involontaire
 - d. **Prise de poids – œdème des MI**
6. Antécédent personnel
 - a. **Infection récente (IVRS)**
 - b. Maladie comorbidités
 - c. Interventions ou hospitalisations
 - d. Allergies
 - e. Médicaments
7. Antécédents familiaux

Examen clinique

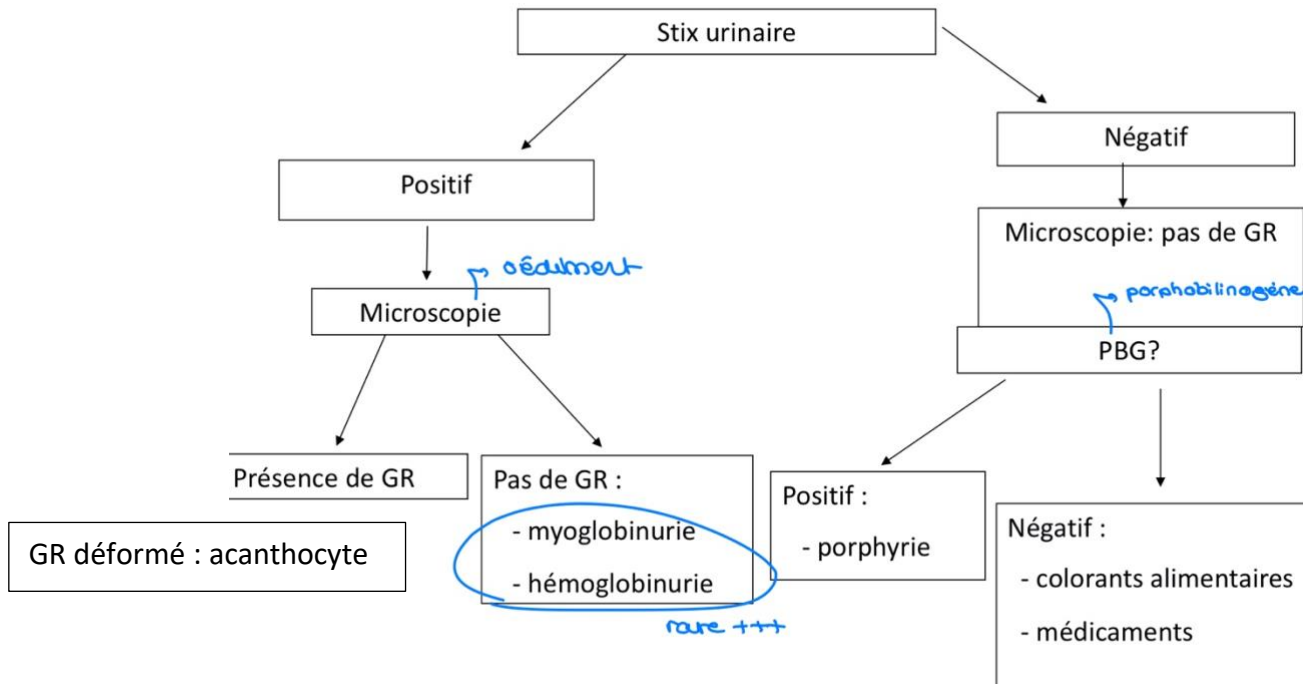
1. Installation
 - a. Bras et jambes décroisées
 - b. Tête légèrement surélevée
 - c. Abdomen entièrement visible
 - d. Se place à droite du patient
2. Inspection
 - a. Visage : malaise, douleur
 - b. Peau : cicatrices, veines dilatées, lésions cutanées, vergetures...
 - c. Omilic
 - d. Allure de l'abdomen : plat, arrondi, symétrie, voussure
 - e. Mouvements : respiratoire, péristaltique, pulsatiles
3. Auscultation (**avant palpation**)
 - a. 4 quadrants (fréquence gargouilles : 5-34/min)
 - b. Aorte
 - c. A. iliaque
4. Percussion
 - a. 4 quadrants
 - b. Délimite la taille du foie
5. Palpation (+ check visage patient, si résistance, le faire en expiration et en respirant par la bouche ouverte, mâchoire tombante)
 - a. 4 quadrants
 - i. Superficielle (1 main)
 - ii. Profonde (2 mains)
 - iii. Détente et défense
 - b. Palpation du foie
 - c. Palpation de la rate
 - d. Palpation des reins**
 - e. Palpation vessie**
6. Percussion des reins
7. Évoquer un toucher rectal + palpation aires inguinales

DD sang dans l'urine

- **Infection urinaire basse** (cystite : pollakiurie, dysurie, hématurie, femme)
- **Calcul néphrétique** (douleur et hématurie)
- **Pyélonéphrite** (percussion rein douloureuse)
- **Cancer** (non douloureux, hématurie initiale ou finale : vessie, hématurie tout au long : rein)
- **Glomérulonéphrite avec syndrome néphritique** (œdème, HTA, créatininémie élevée et oligurie, GR dysmorphique)
 - Glomérulonéphrite post strepto
 - Maladie de Berger - IgA

Examen complémentaire

1. → Pour être sûr que c'est du sang



- FS

Fièvre

Anamnèse

1. Caractériser la fièvre
 - a. Début/durée
 - b. Intensité
 - c. Évolution
 - d. Fluctuation
 - e. Facteurs soulageants
2. Douleurs ?
3. **Symptômes B**
 - a. **Frissons**
 - b. **Transpiration**
 - c. **Perte de poids**
4. Anamnèse par système
 - a. Toux
 - b. Dyspnée
 - c. **Disparition goût ou odorat**
 - d. Céphalées
 - e. **Éruption cutanée**
 - f. Douleurs articulaires
 - g. Douleurs musculaires (courbatures)
 - h. Symptômes digestifs
 - i. Symptômes urinaires
5. Antécédents personnels
 - a. Maladie
 - i. Maladie chronique
 - ii. **Immunosuppression**
 - b. Opération
 - c. Hospitalisation
 - d. **Vaccins**
 - e. Perte de poids récente
6. Habitudes
 - a. **Voyages**
 - b. **Exposition à des malades (enfants, travail en milieu de soin)**
 - c. **Contact avec des animaux**
 - d. Tabac
 - e. **Drogues iv**
 - f. **Sexualité** (type, préservatif)
 - g. Médicaments

Examen clinique

1. **Inspection cutanée (recherche systématique de tout le corps)**
 - a. Recherche d'affection/éruption cutanée
2. Inspection cavité buccale
3. **Palpation des aires ganglionnaires**
 - a. **Cervicales**
 - b. **Axillaires**
 - c. **Inguinales**
4. **Auscultation cardiaque**
 - a. **Foyer aortique**
 - b. **Foyer pulmonaire**
 - c. **Foyer mitral**
 - d. **Foyer tricuspide**
5. Status vasculaire
 - a. Palpation des pouls périphériques
 - b. Temps de recoloration des extrémités
 - c. Œdème ? angioedème ?
 - d. Auscultation des carotides
6. Pulmonaire
 - a. Amplitude
 - b. Percussion (lat + post : délimiter + comparer)
 - c. Auscultation (lat + post : comparer)
7. Rigidité nucale (méningisme)

Drapeaux rouges

- Patient instable (malgré remplissage □ *sepsis*)
 - Insuffisance respiratoire
 - Hypotension/tachycardie
- Fièvre à plus de 39 avec frissons solennels
- Immunosupprimé
 - Radiothérapie + corticothérapie
 - Chimiothérapie
 - Post splénectomie
 - Lymphome
- Souffle cardiaque nouveau +/- signes de dissémination hémotogène
- Atteinte SNC +/- lésion hémorragiques (*septicémie à méningocoque*)
- Retour de voyage
 - *Malaria*
 - *Dengue*
 - *Rickettsios*

Examens complémentaires de débrouillage en absence d'éléments positifs :

- Rx thorax
- Labo : VS, FSC, électrolytes, tests hépatiques
- Tests urinaires

DD

- Infectieux
 - *Abcès (pelviens, abdominaux, dentaires, ...)*
 - **Endocardite**
 - **Méningite**
 - **Pneumonie**
 - **Ostéomyélite**
 - *Sinusite*
 - *Prostatite*
 - *Tuberculose extra-pulmonaire*
 - *Lyme (paralysie, symptômes pseudo-grippaux, érythème migrant)*
 - *Virus : CMV, EBV, HIV, hépatites*
 - *Champignons*
- Maladie inflammatoire
 - Connectivites
 - **Still** (arthrite, adénopathie, pharyngite, fièvre  Ténosynovites, ferritine augmentée *ondulante*)
 - **Lupus érythémateux disséminé** (*rash malaire, photosensibilité, pleurésie, péricardite, arthralgie, perte de poids, fatigue, fièvre*)
 - **Polyarthrite rhumatoïde** (arthrite : MCP – IPP, genou)
 - Vasculite
 - **Horton**
 - **Polymyalgia rheumatica** (*Raideur matinale et douleur symétrique des ceintures, réponse rapide aux CS*)
 - Maladie granulomateuse
 - *Sarcoïdose*
 - *Fièvre méditerranéenne*
 - **Spondylarthrite ankylosante** (*douleur lombaire inflammatoire, > 40, check uvéite*)
- Néoplasie
 - *Hémopathies*
 - *Tumeurs solides*
- Endommagement des tissus
 - *Traumatisme*
 - *Chirurgie*
 - *Infarctus*
 - *Nécrose*
 - *Hématome*
- Transfusion / hémolyse
- **Thrombo-embolie**
- **Hyperthyroïdie / insuffisance surrénalienne**
- *Fièvre médicamenteuse (ATB, médicament CV, allopurinol, phénytoïne)*
- *Fièvre suite à vaccin*
- **Aucun diag ne peut être posé : indéterminé : si investigation profonde et > 3 semaines**

Douleur au mollet

Anamnèse :

- Caractérisation de la douleur
 - Localisation : unilatéral vs bilatéral
 - Irradiation
 - Chronologie
 - Début
 - Circonstance de survenue
 - Évolution (fluctuation)
 - Intensité
 - Qualité
 - Facteurs aggravants/soulageants
- Manifestations associées
 - Rougeur
 - Œdème
 - Chaleur – froid
- **Distance de marche – claudication intermittente**
- Activité physique inhabituelle, **traumatisme**
- Autres symptômes associés
 - Dyspnée
 - Fièvre
- FR thrombo-embolique
 - Voyages récents
 - Immobilisation
 - Hospitalisation
 - Cancer
 - Grossesse
- FRCV
 - Tabac
 - HTA
 - Hypercholestérolémie
 - Diabète
 - ATCD familiaux
- Antécédent
 - Épisode similaire antérieur ?
 - Maladie
 - Hospitalisation/opération
 - Médicaments
 - Allergie
- Habitudes
 - Diète
 - Alcool
 - Tabac
 - Drogues

Examen clinique :

- Local
 - o Rougeur
 - o Pâleur
 - o Signes de Homans
- Cardio-vasculaire
- Pulmonaire
- Neurologique

DD douleur au mollet :

- Artériel
 - o Ischémie des membres inférieurs →
 - o Syndrome de l'artère poplitée piégée
- Veineux
 - o Thrombose veineuse profonde ou superficielle
 - o Syndrome post-thrombotique
- Neurologique
 - o Claudication neurogène
- Musculaire
 - o Contracture- élancement
 - o Courbature
 - o Déchirure – rupture
 - o Syndrome aigu des loges musculaires
 - o Hernies myofasciales isolées
- Métabolique
 - o Maladie de Paget
- Tumoral
- Infectieux
 - o Dermohypodermite
 - o Ostéomyélite

Les 6 P (drapeaux rouges) :

1. **Pain** → douleur, apparition brutale, de type crampe
2. **Pallor** → membre pâle en distalité, temps de recoloration > 3 sec
3. **Polar** → membre froid en distalité
4. **Pulselessness** → pouls périphériques absents (tibial postérieur et pédieux)
5. **Paresthesia** → troubles sensitifs initiaux
6. **Paralysis** → troubles moteurs dans un second temps

Ostéomyélite :

- Fièvre, frisson
- Douleur à la palpation locale

Dermohypodermite :

- Fièvre
- Rougeur, chaleur, œdème

DD claudication intermittente :

- Vasculaire
 - o Thrombose (soulagé couché)
 - o Artériosclérose (soulagé à l'arrêt)
- Neurogène (soulagé à croupi, penché en av., pire en descente et penché en arrière)
 - o Médullaire
 - o Radiculaire
- Articulaire
 - o Post-traumatique
 - o Arthrite

Symptoms	Neurogenic	Vascular
Quality	Pain/numbness/tingling/weakness	Pain/cramping/tightness
Increased with walking	Yes	Yes
Relieved walking flexed with a cart	Yes	No
Relieved standing erect	No	Yes
Relieved sitting/lying	Within minutes	Immediate
Increased walking uphill/upstairs	No/less	Yes
Increased walking downhill	Yes/more	Yes
Increased biking/back flexed	No	Yes
Increased biking/back extended	Yes	Yes

Examen complémentaire :

- AOMI : ABI + US
- TVP : D-dimères + US
- Claudication neurogène : IRM colonne
- Dermohypodermite : hémoc si fièvre + co-amox
- Ostéomyélite : FSC, CRP + hémocultures + imagerie (US/IRM/Rx)

Lombalgies

Drapeaux rouges lombalgies – métastases :

- ATCD de cancer (**sein, poumon, prostate, rein, thyroïde**)
- Âge > 50 ans
- **Perte pondérale**
- **Baisse de l'état général**
- Absence d'amélioration au repos ou en position couchée
- Douleur localisée à la palpation
- Syndrome de la queue de cheval ou de compression radiculaire

Drapeaux rouges lombalgies – spondylodiscite :

- **Toxicomanie iv**
- **Immunodéficience**
- Plaie à proximité
- Baisse de l'état général
- **Symptômes – signes d'endocardite (fièvre, tachycardie, frisson, dyspnée, toux, nouveau souffle, faiblesse, perte poids, sudation nocturnes)**
- Douleur en sonnette (= douleur brutale à 1 loca)
- **Fièvre**
- Douleur inflammatoire (au repos, nocturne, diminue lors d'activité)
- Raideur rachidienne

Drapeaux rouges lombalgies et anévrysme de l'AA :

- HTA
- > 60 ans
- **Douleur abdominale**
- **Masse abdominale pulsatile**
- **Souffles fémoraux**
- Troubles vasculaires des MI
- Syphilis
- Sy. De Marfan

Drapeaux rouges et fracture vertébrale :

- > 50 ans
- **Ostéoporose connue**
- **Corticothérapie longue durée**
- Traumatisme
- Déformation du rachis
- Douleur localisée à la palpation sy de la queue de cheval ou de compression radiculaire (rare)

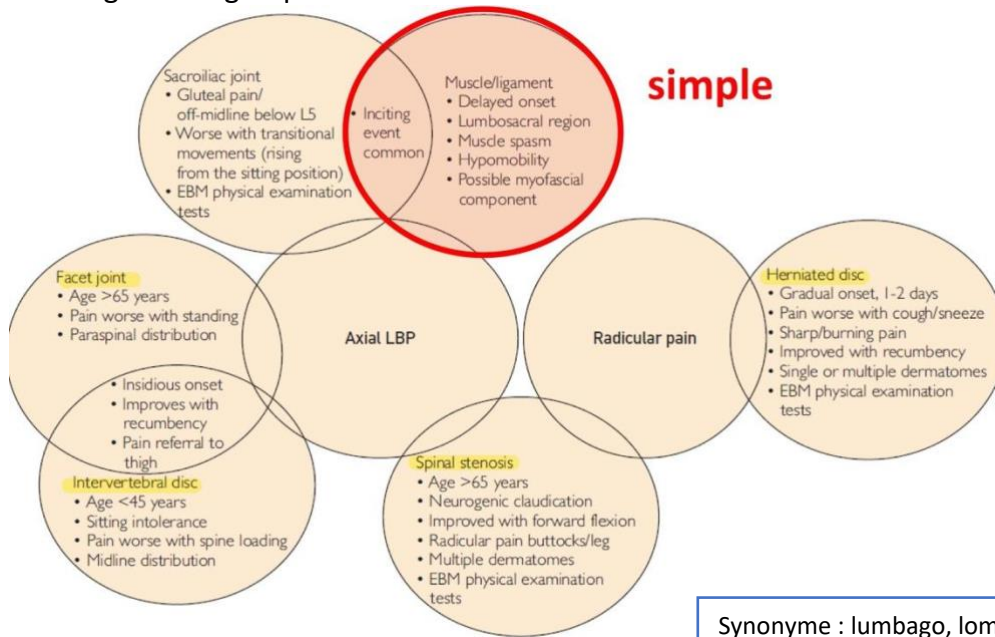
Drapeaux rouges lombalgie et syndrome de la queue de cheval :

- Déficit moteur
- Déficit du réflexe achilléen
- Déficit sensitif selon dermatome
- Troubles sphinctériens : globe urinaire, hypotonie sphinctérienne anale au TR.

Examen clinique

1. Marche
 - a. Normal
 - b. Talon
 - c. Pointe
2. Romberg
3. Inspection
 - a. Latéralement (LCL)
 - b. Postérieurement (scoliose)
 - c. Regarder colonne quand se penche en avant
4. Palpation
 - a. Épine iliaque □ chez hauteur
 - b. L4-L5 □ articulation sacro-iliaque (même ligne qu'épine)
 - c. Muscle paravertébraux
5. Percussion
 - a. Vertèbres
6. Examen
 - a. Cervicale
 - Dire oui de la tête – dire non
 - Toucher l'épaule avec l'oreille
 - b. Lombaire (DEBOUT)
 - Se pencher en avant
 - Se pencher un peu en arrière
 - Se pencher de chaque côté
 - **Test de Schober** : mettre le pouce sur L5 et mettre l'index sur le processus épineux 10 cm plus haut □ patient se penche en avant □ 15 cm entre les doigts si normal
 - **Signe de la sonnette** : appuyer fort sur la vertèbre □ signe positif si patient se crispe □ suspicion de radiculopathie et décharge latérale à la jambe jusqu'à derrière le genou
 - c. Thoracique
 - Patients ASSIS □ tourner les épaules les bras croisés
 - d. COUCHER
 - **Test de lasègue L5-S1** : test + si décharge dans la jambe entre 40° et 60°
 - **Test de Bragard** : = test de lasègue avec dorsiflexion
 - **Lasègue inversé L3-L4**
7. Examen neuro ciblé
 - a. Sensibilité
 - b. Motricité
 - c. Réflexe
 - d. Sphincter
8. Toucher rectal

Lombalgie étiologie spinale :



Lombalgie aiguë simple

Symptômes et signes :

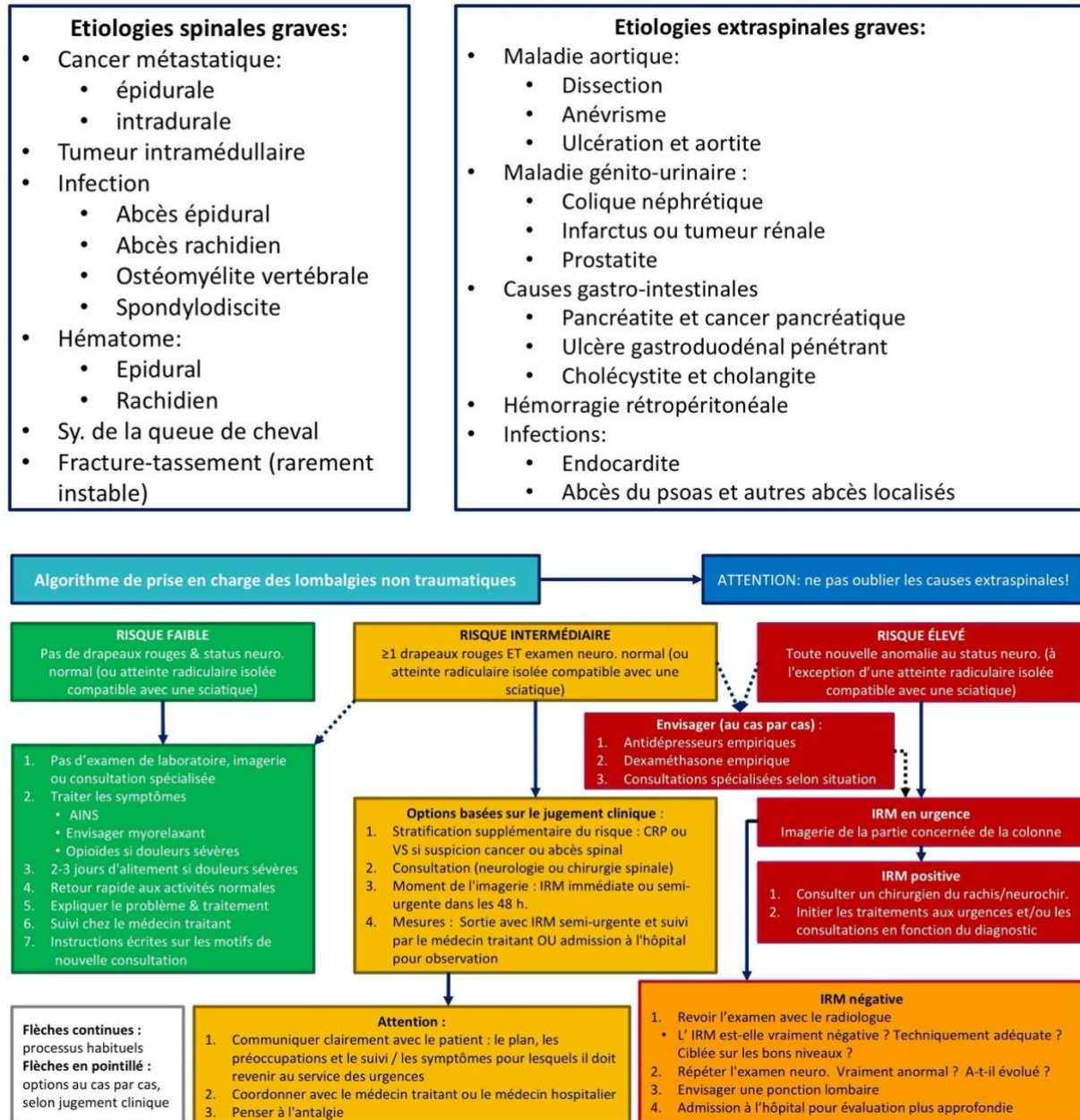
- Localisée en lombaire diffuse
- Début rapide après un effort
- Irradiation lombaire (avec composante de sciatalgie)
- Intensité légère à sévère
- Douleur mécanique (améliorée au repos, augmentée au mouvement)
- Pas de symptômes associés
- Pas de troubles sphinctériens
- ATCD de lombalgie aiguë
- Examen neurologique normal, éventuellement lasèque +

Prise en charge :

- Rassurer, expliquer la nature bénigne de l'affection tout en prenant au sérieux les plaintes □ anamnèse et status permettent d'exclure une maladie grave
- Pas besoin d'imagerie
- Antalgie :
 - **AINS** (ibuprofène)
 - Ev. Tramadol si AINS inefficace mais pas plus de 5 jours
 - Appliquer du froid / de la chaleur
- Médecine manuelle – ostéopathie
- Acupuncture
- Relaxation
- Physiothérapie post phase aiguë

Synonyme : lumbago, lombalgie, lombosciatalgie, syndrome lombo-vertébral, syndrome radiculaire irritatif non déficitaire

Résumé :



Perte de vue – amaurose

Anamnèse

- Caractérisation de la cécité
 - Localisation
 - Chronologie
 - Condition de survenue
 - Développement : subit-progressif
 - Perte de connaissance associée
- Céphalée associée ?
 - Localisation
 - Irradiation
 - Qualité
 - Chronologie
 - Circonstance de survenue
 - Début
 - Évolution
 - Intensité
 - Facteur soulageant – empirant
- Anamnèse par système neurologique
 - Diplopie
 - Perte de force
 - Perte de sensibilité
 - Paresthésie
 - Vertiges
- Anamnèse par système générale
 - Fièvre
 - Sudations nocturnes
 - Perte de poids
- Habitudes
 - Tabagisme
 - Alcool
 - Drogue
- ATCD et comorbidité
 - Maladie
 - Opération
 - Hospitalisation
 - Allergies
 - Médicaments

AVC URGENCE

- **Paralysie du visage**
- **Paralysie du bras ou jambe**
- **Trouble de la parole**
- **Trouble de la vue**
- **Vertiges violents**
- **Maux de tête intense**

Examen clinique :

- Ophtalmologique
 - Inspection
 - Sclère
 - Paupière
 - Acuité visuelle
 - Œil droit – gauche
 - Fond d'œil
- Neuro-ophtalmologique
 - Champs visuels
 - Poursuite oculaire – oculomotricité
 - Réflexes pupillaires
 - Direct
 - Croisé
- Neurologique
 - Motricité
 - Sensibilité
- DD AVC : test de Cincinnati
 - Motricité de la face NII
 - Épreuve des bras tendus
 - Répétition d'une phrase
- DD horton
 - Percussion de l'artère temporale
 - Palpation de la mâchoire
- Cardiaque
 - Auscultations carotide
 - Auscultation des 4 foyers

Glaucome : œil rouge, douleur, mal à la tête, halo autour des lumières, pert en périph

Décollement rétine : éclairs,

DMLA : metamorphosis,

Décollement du vitré : mouches qui volent

cataracte : voit moins les couleurs vives, vision trouble, perte du réflexe rouge, éblouissement

Differential diagnosis of vision loss		
Condition	Clinical features	Fundoscopy
AMD	• May be insidious (dry AMD) or rapid (wet AMD) onset • Impairment of central <u>vision</u> only (vision loss is rare)	• <u>Drusen</u> • <u>Macula</u> depigmentation
Open-angle glaucoma	• Insidious onset • Peripheral vision loss (tunnel vision)	• Disc cupping with high intraocular pressure
Central retinal artery occlusion	• Acute or subacute onset • Complete <u>vision loss</u>	• Swollen disc • Retinal hemorrhages • <u>Cotton wool spots</u>
<u>Retinal detachment</u>	• Acute onset • Partial or complete <u>vision loss</u> (falling curtain)	• Detached or floating <u>retina</u>
Cataract	• Insidious onset • Blurred, dim <u>vision</u>, and a glare • Absent or opacified red-reflex	• <u>Retina</u> may not be visible (in advanced disease)

Céphalées

Anamnèse :

- Qu'est-ce qui vous amène ?
- Comment est-ce que ça a commencé ?
- Et depuis vous avez régulièrement mal à la tête ?
- Tous les jours ?
- Combien de fois par semaine ?
- C'est chaque fois la même chose ?
- C'est où ces douleurs ? Pas uniquement d'un côté ?
- Vous avez l'impression que ça sert ?
- Est-ce que vous sentez des pulsations ?
- Est-ce qu'il y a des moments dans la journée où ça vient plus volontiers ?
- Ça dur combien de temps ?
- Est-ce que ça arrive le matin ?
- Est-ce que ça vous empêche de dormir la nuit ?
- Est-ce qu'il y a quelque chose qui aggrave ces douleurs ou qui les fait venir ?
- Est-ce qu'il y a quelque chose qui soulage les douleurs ? Est-ce que ça vous est arrivé de prendre des médicaments ?

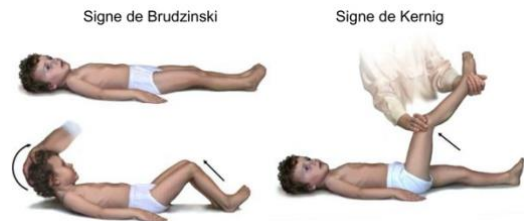
Céphalée

1. Rechercher des **drapeaux rouges**
 - a. **Type de douleur**
 - i. **Pas comme d'habitude, différente** (surtout si > 50 ans)
 - ii. **La pire**
 - iii. **En coup de tonnerre +/- céphalée sentinelle (HSA)**
 - iv. **Positionnelle, à l'effort** (*hémorragie, rupture anévrisme*)
 - v. **Profil évolutif défavorable**
 - b. **Contexte**
 - i. **Grossesse / post-partum** (*thrombophlébite*)
 - ii. HIV, immunosuppression
 - iii. Anticoagulant, consommation d'alcool
 - iv. **Traumatisme crânien**
 - v. Manipulation ou trauma nuque
 - vi. **Baisse de l'état général, perte de poids** (cancer, métastase)
 - c. Clinique
 - i. **Symptômes neuro récents** inhabituels – examen neuro anormal
 1. Mydriase
 2. myosis + ptosis (Horner) (*dissection carotidienne*)
 - ii. Horton
 1. Douleurs temporales en lien avec l'a. temporale
 2. Douleurs au passage du peigne ou de la mastication
 3. Douleurs ceintures
 4. Altération de l'état général
 - iii. **Rash – éruption cutanée**
 - iv. **Méningisme – raideur de nuque**
 - v. **Fièvre** sans autre foyer clinique
 - vi. HTA sévère > 180/120 – hypertension maligne
2. Caractérisation des céphalées
 - a. Durée des céphalées - évolution
 - b. Localisation : douleur unilatérale vs bilatérale
 - c. Caractère : pulsatile vs pression – étai
 - d. Intensité
 - e. Aggravation ou pas par les activités physiques de routine
 - f. Nausée, vomissement
 - g. Photophonophobie
 - h. Aura (signes positifs)
3. Symptômes associés
 - a. Injection conjonctivale, larmolement
 - b. Sensation de plénitude de l'oreille
 - c. Congestion nasale
 - d. Myosis, ptosis
 - e. Sudation, rougeur du front et de la face
 - f. Œdème de la paupière
 - g. Agitation
4. ATCD personnel
 - a. Maladie – hospitalisation – opération

- b. Médicaments
- c. Allergies
- 5. ATCD familiaux
- 6. Habitude
 - a. Diète - Tabac – alcool – drogue (**cocaïne**) – AP

Examen clinique :

- Examen neurologique
 - o Orientation – niveau attentionnel
 - o Station debout et marche
 - o Épreuves cérébelleuses
 - o Nerfs crâniens
 - o **Signe méningé (Brudzinski, Kernig)**
 - o Signes de latéralisation : voies longues (grossièrement)
 - o **Cincinnati : bras tendu + n. VII + répéter phrase après moi**
 - o FO
- **Rash → inspection de tout le corps**
- **Auscultation carotidienne** et cardio
- Examen dirigé selon l'anamnèse :
 - o **Palpation des artères temporales**
 - o ORL – percussion des sinus
 - o Stomatologique – examen dentition
 - o Palpation ATM
 - o Rachis cervical



Laboratoire

- VS si céphalée inaugurale à > 50 ans – suspicion Horton
- FS, hémocultures si suspicion méningite
- Crase si suspicion hémorragie ou pathologie chirurgicale
- PL si suspicion HSA, méningite ou méningite carcinomateuse

Imagerie

- CT si signe d'alarme sauf si suspicion méningite ou artérite temporale
- IRM si suspicion pathologie fosse post., charnière occipitale, pathologie vasculaire

DD :

- *Céphalée primaire :*
 - o *Migraine*
 - o *Céphalée de tension*
 - o *Névralgie du trijumeau*
 - o *Névralgie occipitale*
 - o *Cluster headache*
- *Céphalée secondaire*
 - o *AVC*
 - o *Méningite*
 - o *Hémorragie sous arachnoïdienne*
 - o *Hématome sous-dural*
 - o *Dissection (carotidienne ou vertébrale)*
 - o *Thrombophlébite – thrombose veineuse*
 - o *Cancer – métastase*
 - o *Artérite temporale – Horton*

Migraine épisodique (< 15j/mois)

Symptômes :

- Céphalées durent **4 à 72 heures** (sans ttt)
- **Au moins 2** des caractéristiques suivantes
 - o Localisation **unilatérale**
 - o Caractère **pulsatile**
 - o Intensité **modérée à sévère**
 - o **Aggravation par les activités** physique de routine
- **Au moins 1** des caractères suivants
 - o **Nausée / vomissement**
 - o **Photophonophobie** (aggravée par la lumière et par le bruit)

Traitement :

- Crise
 - o AINS – paracétamol
 - o Triptan
- De fond
 - o Beta-bloquant
 - o Anti-calcique
 - o Anti-épileptique
 - o Antidépresseurs tricycliques
 - o Anticorps monoclonaux

Céphalées de tension

Symptômes :

- Céphalée dure de **30 minutes à 7 jours**
- **Au moins 2** des caractéristiques suivantes
 - o Localisation **bilatérale**
 - o A type de **pression ou d'étouffement**
 - o Intensité **légère à modérée**
 - o **Non aggravée par les activités** physiques de routine
- Aucun des caractères suivants
 - o **Nausée/vomissement**
 - o **Photophonophobie**

Traitement :

- Crise : AINS
- Traitement de fond
 - o Médicamenteux : antidépresseurs tricycliques
 - o Non médicamenteux : relaxation, acupuncture, gymnastique posturale

Algie vasculaire de la face = céphalées en grappe = cluster headache

C'est une hémicrânie trigémino-dysautonomique. Les patients rapportent des douleurs très sévères unilatérales orbitaire, supra-orbitaire, temporelle pendant **15 à 180 minutes**.

Pour poser le diagnostic il faut **au moins 1** des signes suivants, **du côté** de la douleur :

- Œil rouge
- Injection conjonctivale, larmolement
- Sensation de plénitude de l'oreille
- Congestion nasale ou rhinorrhée
- Myosis ou ptosis
- Sudation du front et de la face
- Rougeur du front et de la face
- Œdème de la paupière
- **Agitation**

Traitement :

- Crise
 - o O₂ masque avec 10-12 l pendant 15 minutes
 - o Triptan
- De fond
 - o Anticalciques

Céphalées et névralgies occipitales

- Névralgies du nerf d'Arnold
 - o Territoires des nerfs grands et petits occipitaux
 - o En coup de poignard
 - o Provoquée par des mouvements de la tête
 - o Sensibles à la palpation
 - o Douleur soulagée temporairement par un bloc local (permet diag)
- Névralgies trigéminales
 - o Femme après 50 ans
 - o Douleurs brèves (sec.) mais répétées (jusqu'à 100x/j)
 - o Décharge électrique ou brûlure dans territoire du trijumeau (une ou plusieurs branches)
 - o Zone gachette : toucher, parler, brossage des dents, manger
 - o Porte la main au visage qui se crispe (tic douloureux)
 - o Pas d'hypoesthésie

DD :



<u>Syndrome méningés</u>	<u>Hypertension intracrânienne</u>	<u>Hypotension intracrânienne</u>
Position allongée en chien de fusil	Prédominant en décubitus, le matin au réveil	Prédominant en orthostatisme
Nausée, vomissement	Nausée, vomissement en jet , le matin au réveil	Nausée après orthostatisme prolongé
Raideur douloureuse de la nuque	Flou visuel et œdème papillaire au fond d'œil (+/- atteinte de n. VI → diplopie)	Acouphènes , troubles « fonctionnels » divers
Hémorragie méningée (apyrétique, brutal), méningite (pyrétique)	Thrombophlébite cérébrale (favorisé par facteurs pro-thrombotique + infection ORL → céphalées, déficit neurologique, crise d'épilepsie), Processus expansif, HTIC idiopathique (obèse)	Fuite du LCR (spontanée ou post PL ou post-périturale, y penser en post-partum) Diag : IRM → pachyméningite Voir PL
TTT : dexaméthasone et céftriaxone		

Céphalées

1. AA

- onset
- location
- qualité
- intensité
- durée
- timing (empêche de dormir)
- symptômes neurologiques associés (photophobie, auras, ataxie)
- nausées/vomissements
- claudication de la mâchoire
- trauma récent
- chirurgie dentaire
- sinusite
- facteurs aggravants
- facteurs qui soulagent
- AF
- ancien trauma

2. Status

- signes vitaux
- inspection/palpation du crâne
- ORL
- examen neurologique
- fond d'œil

3. DD

- migraine
- céphalées cluster
- artérite temporale (Horton)
- sinusite
- migraine de tension
- HSA
- méningite
- névralgie du trijumeau
- pseudotumeur cérébrale

Parésie

Anamnèse

1. Caractériser

a. Condition de survenue ?

- i. Brutal ?
- ii. Traumatisme ?
- iii. Depuis quand ?
- iv. Évolution ?

b. Signes associés ?

- i. Trouble de la parole ?
- ii. Trouble de la vue ?
- iii. Trouble de l'audition ?
- iv. Vertiges ?**
- v. Céphalées intenses ?**

c. Localisation

- i. Membre touché ? Quel mouvement ?

d. Facteurs aggravants/soulageant

e. Matin mieux que le soir ?

2. Symptômes associés

a. Douleur

- i. Localisation
- ii. Irradiation
- iii. Qualité

1. Brûlures

2. Décharge électrique

- iv. Intensité
- v. Chronologie
- vi. Facteurs aggravants / soulageant
 - 1. Effort
 - 2. Toux

b. Paresthésie (fourmillement) (+ localisation et autre caractérisation)

c. Hypoesthésie (+ localisation et autre caractérisation)

- d. Atrophie
- e. Autre ?

3. Marche

- a. Symptômes apparaissent après distance fixe ?
- b. Toujours présent

4. Système digestif

a. Selles → faire TR

- i. Incontinence, fuites
- ii. Constipation

b. Urines

- i. Incontinence, fuites
- ii. Vidange incomplète

AVC URGENCE

- **Paralysie du visage**
- **Paralysie du bras ou jambe**
- **Trouble de la parole**
- **Trouble de la vue**
- **Vertiges violents**
- **Maux de tête intense**

5. ATCD personnels
 - a. Symptômes similaires par le passé
 - b. Maladie
 - c. Hospitalisation
 - d. Opération
 - e. Médicaments
 - f. Allergie
6. ATCD familiaux
7. Habitudes
 - a. Tabac
 - b. Alcool
 - c. Drogue

DD

- **AVC/AIT**
- **Trauma moelle**
 - o **Totale**
 - o **Hémi-moelle** (hémiparésie + dissociation entre côté atteint proprioception et sensibilité douleur/chaleur)
 - o **Antérieur** (hémiparésie + abolition thermoalgésie alors que tactile ok)
- **Myélopathie** (démarche ataxique, perte motricité fine, parésie, hyperréflexe, signes pyramidaux : Babinski +)
 - o *Mécanique : canal étroit, hernie, processus expansif, hématome, traumatisme, abcès épidural)*
 - o *Métabolique : myélose funiculaire (déficit B12)*
 - o *Infectieux : polio, coxsackie, herpès, EBC, CMV, HIV, syphilis, lyme, maladie de Pott*
 - o *Inflammatoire : SEP, lupus, Sjögren*
 - o *Vasculaire : ischémique (début subaigu)*
 - o *Paranéoplasique : cancer pulmonaire, lymphome, ...*
- **Syndrome radiculaire**
 - o *Irritatif* (Douleur neuropathie intense unilatérale (dermatome), paresthésie, majoré par l'effort, la toux + reproductible par l'étirement)
 - o *Déficitaire* (hypoesthésie, parésie (myotome) + abolition réflexe, atrophie)
- **Polyneuropathie** (= purement sensitif au début, distal, bilatérale, symétrie, synchrone, pts diabétique)
- **Polyradiculoneuropathie chronique** (prédominance motrice, atteinte sensitive surtout proprioception → trouble de la marche, instabilité, non longueur dépendant, +/- symétrique)
- **Polyradiculoneuropathie aiguë : Guillain-Barré** (prédominance motrice, atteinte sensitive surtout proprioception → trouble de la marche, instabilité, non longueur dépendant, +/- symétrique + précédé d'un **épisode infectieux respiratoire ou digestif**, ! on ne fait qu'un Guillain-Barré dans sa vie)
- **Myasthénie** (ptosis, paralysie faciale, dysphagie, faiblesse nuque, difficulté de tenir les bras tendus et les jambes fléchies, mieux le matin que le soir, dépend de la fatigue)
- **Sclérose latérale amyotrophique** (uniquement motrice, faiblesse, amyotrophie, fasciculations,, crampes → atteinte du 1^{er} et du 2^{ème} motoneurone)

Examen clinique

Faire examen neuro normal

1. Orientation

- a. Comment vous-vous appelez ?
- b. Où êtes-vous ?
- c. Quelles dates sommes-nous ?

2. Cincinatti pour suspicion AVC :

- a. Motricité de la face NII
- b. Épreuve des bras tendus
- c. Répétition d'une phrase

3. Marche

- a. Normal
- b. Pointe / talon +/- funambule

4. Romberg (main tendue d'abord yeux ouverts ensuite avec fermés)

5. Nerfs crâniens

6. Inspection - palpation muscle → amyotrophie ?

7. Membre sup force contre résistance

- a. Épreuve bras tendu (DDC)
- b. Abduction latérale (DDC)
- c. Rotation latérale épaule (DDC)
- d. Flexion avant-bras
- e. Extension bras
- f. Flexion poignet
- g. Extension poignet
- h. Abduction des doigts (ouvrir doigt contre pression)
- i. Flexion des doigts (doigt en crochet)
- j. Extension des doigts (paume vers le bas)

8. Réflexe (!!! comparer des 2 côtés)

- a. Tricipital (C7)
- b. Bicipital (C6)
- c. Stylo-radial (C6)
- d. Rotulien (L3-L4)
- e. Achilléen (S1)

9. Membre inf force contre résistance

- a. Épreuve jambes fléchies
- b. Flexion hanche
- c. Extension hanche (main sous pied)
- d. Flexion genou
- e. Extension genou
- f. Flexion pied (tirer patient en bas de la table)
- g. Extension pied
- h. Flexion gros orteil
- i. Extension gros orteil

10. Babinski

!!! si symptômes
seulement MI depuis dos
→ faire examen du rachis +
neuro membre inf +
lasègue et lasègue inversé

11. Sensibilité

- a. **Tact global**
- b. Piqûre global
- c. Toucher – piquer
- d. Position doigt – orteil
- e. Pallesthésie poignet / cheville

!!! faire toucher piquer, sensibilité profonde (position doigt), pallesthésie etc seulement si plainte de la sensibilité globale ou de la sensibilité à l'anamnèse

Vertiges

AVC URGENCE

- Paralysie du visage
- Paralysie du bras ou jambe
- Trouble de la parole
- Trouble de la vue
- Vertiges violents
- Maux de tête intense

1. Rechercher des drapeaux rouges
 - a. **Céphalées** inhabituelles
 - i. *Est-ce que vous avez aussi mal à la tête ?*
 - b. Début **soudain**
 - i. *Comment est-ce que c'est apparu ?*
 - c. **Ne tient pas debout** (périphérique arrive à tenir mais ont peur)
 - i. *Est-ce que vous arrivez à marcher ?*
 - d. Anomalie neuro
 - i. Dysarthrie, Dysphagies, Diplopie, Dysphonie
 1. *Est-ce que vous trouvez que vous avez de la peine à articuler ?*
 2. *Est-ce qu'on vous demande de répéter ce que vous dites parce qu'on a de la peine à comprendre quand vous parlez ?*
 3. *Est-ce que vous avez de la peine à avaler ?*
 4. **Diplopie binoculaire** / parésie oculomotrice (**jamais de diplopie si vertige périphérique**) : *Est-ce que vous voyez double ?*
 - ii. **Nystagmus**
 1. Vertical
 2. Multidirectionnel
 3. Dysconjugué (les deux yeux ne font pas la même chose)
 4. **Horizonto (rotatoire) est en général périphérique (DVB)**
 - iii. **Hémisyndrome** spinothalamique (douleur, chaleur)
 - iv. **Hoquet**
 1. *Est-ce que vous avez eu le hoquet ?*
 - v. Syndrome de **Horner** (myosis, ptosis)
 - vi. **Skew deviation** = divergence vertical statique et non paralytique de la position des yeux. Des fois sans diplopie, mise en évidence avec le **alternate cover test** (couvrir alternativement chaque œil et voir s'il existe une saccade de correction verticale)
2. Caractériser le vertige
 - a. Constant ? au mouvement, brusque ?
 - b. Pièce qui tourne ? ou comme si tangué ?
3. Autres symptômes ?
 - a. Nausée – vomissement
 - b. Autre
4. ATCD personnels
5. ATCD familiaux
6. Habitudes
 - a. Tabac
 - b. Alcool
 - c. Drogue

4D

4H
Hoquet
Horner
Hémisyndrome
Hallux (Babinski)

Examen clinique

- Orientation
 - Comment vous-vous appelez ?
 - Où êtes-vous ?
 - Quelles dates sommes-nous ?
- Marche
 - Normal
 - Pointe / talon
 - **Funambule**
- **Romberg (main tendue d'abord yeux ouverts ensuite avec fermés)**
- **Doigt-nez**
- **Marionnette**
- **Rebond pathologique**
- **Talon-genou-descendre le long du tibia**
- **Réflexe (!!! comparer des 2 côtés)**
 - Tricipital (C7)
 - Bicipital (C5)
 - Stylo-radial (C6)
 - Rotulien (L3-L4)
 - Achilléen (S1)
- **Hallpike**
- **Head impulse test**
- Palpation muscle
- Nerfs crâniens
- Membre sup force contre résistance
 - Épreuve bras tendu (DDC)
 - Abduction latérale (DDC)
 - Rotation latérale épaule (DDC)
 - Flexion avant-bras
 - Extension bras
 - Flexion poignet
 - Extension poignet
 - Abduction des doigts (ouvrir doigt contre pression)
 - Flexion des doigts (doigt en crochet)
 - Extension des doigts (paume vers le bas)
- Membre inf force contre résistance
 - Épreuve jambes fléchies
 - Flexion hanche
 - Extension hanche (main sous pied)
 - Flexion genou
 - Extension genou
 - Flexion pied (tirer patient en bas de la table)
 - Extension pied
 - Flexion gros orteil
 - Extension gros orteil
- Babinski
- Sensibilité : tact global



Patho yeux ouverts : cervelet Patho yeux fermés seulement : vestibulaire
--

DD

AVC (syndrome cérébelleux aigu) :

- Vertiges intenses d'installation brusque
- Impossibilité à tenir debout
- Nausées, vomissement
- Céphalées
- **Déficit neurologique** (<50%) → NIHSS 0
 - o Symptômes du TC
 - Diplopie
 - Dysarthrie
 - Dysphagie
 - Hoquet
 - Nystagmus

Gayer- Wernicke :

Se présente chez des pts éthylique et dénutri. On observe les symptômes suivants :

- Confusion
- Nausée
- Oscillopsie
- Trouble de l'équilibre
- Dysarthrie
- **Troubles oculomoteurs**
 - o Ophtalmoplégie
 - o Nystagmus spontané
 - o Ataxie oculaire
- **Confusion**
- **Ataxie statique / cinétique**

Triade

	DVB	VPPB
Physiopathologie	Neuropathie du n. VII → déficit d'input unilatéral se manifestant sur le plan horizontal	Cristal dans un canal semi-circulaire → suractivation paroxystique d'un canal
Chronologie	Constant	Aux mouvements
Clinique	Grands vertiges et nystagmus constants Syndrome vestibulaire harmonieux Nausées, vomissement	Vertiges et nystagmus brusques Nausée, vomissement
Nystagmus	Horizonto-rotatoire (battant du côté de l'oreille saine) Constant	Selon l'axe du canal touché
Test diagnostic	Manœuvre de Halmagyi = Head impulse test	Manœuvre de Hallpike (supine roll test pour le canal horizontal)

Vertiges

1. AA

- lipothymie vs. vertiges
- symptômes auditifs (perte auditive, acouphène)
- durée
- contexte (position, suite à un trauma)
- symptômes associés (troubles visuels, nausées, infections des voies aériennes supérieures)
- douleurs cervicales, blessure
- médication actuelle
- antécédents d'ATS, FRCV

2. Status

- signes vitaux
- examen neurologique complet
- Romberg (examen se fait sans les chaussures, pieds joints et bras tendus devant, position maintenue d'abord avec les yeux ouverts, puis fermés)
- nystagmus
- Tilt (avec table d'inclinaison) ou Hallpike test (patient assis, tête orientée à 45° vers l'oreille testée et allonger le patient avec nuque en extension et attendre 1 minute)
- Head impulse test ou Halmagyi
- démarche
- audition
- Weber et Rinne
- examen ORL
- examen CV

3. DD

- Maladie de Ménière (acouphènes, nausées, perte d'audition)
 - o FSC, sérologie syphilis, IRM, Hallpike négatif
- hypotension orthostatique sur déshydratation
 - o A debout-assis, FSC, électrolytes, leucocytes selles
- hypotension orthostatique médicamenteuse
 - o TA debout-assis, FSC, électrolytes, ECG, IRM
- vertige positionnel bénin (vertiges sur certains mouvements, chambre tourne autour)
 - o Hallpike positif, IRM, audiogramme
- labyrinthite (perte d'audition, nausées, infections des voies aériennes supérieures)
 - o audiogramme, IRM
- neurinite vestibulaire (nausées, infections des voies aériennes supérieures, pas de perte d'audition)
 - o FSC, électrolytes, IRM
- neurinome (perte d'audition progressive unilatérale)

4. Significations des tests

- Romberg latéralisé (syndrome vestibulaire central ou périphérique), Romberg positif (atteinte proprioceptive, déviation lors de la fermeture des yeux ou aggravée par la fermeture des yeux), Romberg négatif (syndrome cérébelleux, instabilité non aggravée par la fermeture des yeux)

- nystagmus périphérique quand unidirectionnel (vestibule, nerf vestibulaire VIII, noyau vestibulaire) et nystagmus central si multidirectionnel
- Hallpike : si nystagmus alors vertige paroxystique positionnel bénin (otolithes dans canaux semi-circulaires antérieurs)
- Halmagyi : si un œil doit faire une cascade correctrice alors déficit vestibulaire (saccade correctrice quand on tourne la tête du patient à droite = déficit canalaire droit)
- Weber (latéralisation du côté atteint si surdité de transmission, latéralisation du côté sain si surdité de perception)
- Rinne (surdité de transmission si $CA < CO$, surdité de perception si $CA = CO$)

Œil rouge

Anamnèse:

- Symptômes oculaires
 - o Chronologie:
 - Aigu?
 - Durée?
 - Récidive?
 - o **Uni vs bilatéral**
 - o **Douleur**
 - o **Prurit**
 - o **Corps étranger**
 - o **Vision**
 - **Acuité visuelle**
 - **Diplopie**
 - o **Photophobie**
 - o **Sécrétions**
- Symptômes généraux
 - o Notamment **uro-génitaux**
 - o Céphalée
 - o Éruption cutanée
 - o Arthralgie
- Antécédents :
 - o Ophtalmologiques (opération !)
 - o Trauma (physique, chimique, UV)
 - o Allergies
 - o Maladie chronique
 - o **Médicaments**
- Contexte :
 - o Contacts
 - o Environnement (famille, professionnel)
 - o **Verres de contact**

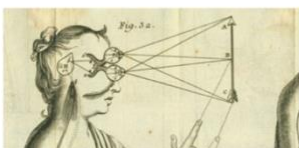
Examen clinique :

« Examen d'un œil rouge »: V-P-C-C-P

1. Vision-général:

Acuité visuelle, champ visuel

Aspect général ? Atteinte uni- ou bilatérale ? Tonus oculaire



2. Paupières

Ouverture, tuméfaction, inflammation, bord, région périoculaire, ganglion préauriculaire

unisanté
Centre universitaire de médecine générale
et santé publique - Louvain



3. Conjonctive :

localisation, type, intensité de la rougeur (ciliaire?); corps étranger, sécrétions (aqueuses, mucineuses, purulentes), papilles, follicules



4. Cornée :

transparence, ulcère, corps étranger, Hypopyon ? Hyphema ?



5. Pupilles :

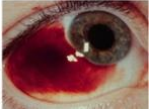
Isocores, réactives?



Drapeaux rouges → consultation ophtalmique :

- **Baisse de l'acuité visuelle**
- **Diplopie**
- Douleur aigüe
- **Céphalées**
- ATCD intervention chirurgicale
- **Œil unique**
- Traumatisme
- Zona ophtalmique
- Anisocorie nouvelle
- Exophtalmie nouvelle
- Cave: porteur lentille de contact
- **Symptômes uro-génitaux → chlamydia – gonorrhée**

DD :

- **Conjonctivite allergique** : 2 yeux rouges, prurit, larmoiement, conjonctive palpébrale folliculaire, atopie
- **Conjonctivite virale** : 2 yeux rouges (1 plus que l'autre parfois), larmoiement, sensation de CE, sécrétions séro-muqueuses, conjonctives palpébrales folliculaire, ganglion, IVRS en cours
- **Kératoconjonctivite épidémique (adénovirus)** : rougeur bilatérale, aigu, douleurs, sensation de CE, vue diminuée, sécrétion → ophtalmo pour surv. kératite
- **Conjonctivite herpétique (simplex – zoster)** : lésions cutanées, unilatéral, rougeur, douleur, *photophobie*, vue diminuée → ophtalmo pour surv. (kératite, uvéite)
- **Conjonctivite bactérienne** : unilatéral, gêne, sécrétion purulente, conjonctives hyperémiées, penser à chlamydia et gonocoque en absence d'amélioration ou lors d'apparition hyperaiguë → ophtalmo
- **Conjonctivite irritative** : lors de yeux secs (hiver, Sjögren), de traumatismes, de verres de contact, de maladie de Basedow ou de maladies systémiques
- **Hyposphagma – hémorragie sous-conjonctivale** : rougeur circonscrite, pas de gêne, pas de douleurs, vue ok, suite à un valsalva, traumatisme, HTA ou spontané → ophtalmo si récidive 
- **Uvéite antérieure** : rougeur, *injection périkeratite*, douleurs, *photophobie*, vision trouble, hypopion, pas de sécrétion, cause : idiopathie, infectieuse, auto-immune (associé à des arthralgies, fatigue), sarcoïdose, systémique (HLA B-27) → ophtalmo 
- **Épisclérite** : rougeur localisée – sectorielle, sclère visible entre les vaisseaux, respecte l'iris, sécrétions
- **Pterygion** : rougeur localisée – sectorielle, ne respecte pas l'iris
- **Blépharite** : croûte matinale, gêne, sécrétions, œdème palpébral, pas de douleurs, vue sp 
- **Chalazion** : œdème palpébral circonscrit, vue sp 
- **Orgelet** : abcès d'un follicule pilo-sébacé du cil
- **Ectropion**
- **Glaucome aigu** : HTA, douleurs +++, rougeur diffuse, *photophobie*, vision trouble, halo, pupille fixe, tonus oculaire augmenté → ophtalmo en urgence

Psychiatrie

1. MOTIF DE CONSULTATION

2. ELEMENTS ANAMNESTIQUES

- **Anamnèse actuelle**
 - Explorer les plaintes principales du patient et les symptômes actuels
 - Investiguer le contexte d'apparition du problème et des symptômes : début, durée, intensité, évolution et présence d'évènements déclencheurs.
 - Explorer les répercussions du problème et des symptômes dans la vie du patient, notamment dans les sphères sociales, familiales et professionnelles.
- **Antécédents psychiatriques personnels**
 - Investiguer les antécédents d'hospitalisation en milieu psychiatrique, de suivi psychiatrique ou psychologique ambulatoire et l'historique des traitements psychotropes.
- **Antécédents psychiatriques familiaux**
 - Investiguer la présence de pathologies psychiatriques héréditaires ou non dans la famille.
 - Investiguer comment le patient l'a vécu, l'impact sur lui
- **Anamnèse socioprofessionnelle et familiale**
 - Profession (certaines professions sont plus à risque d'épuisement), activité occupationnelle ou source de revenu (Revenu d'Insertion, Assurance Invalidité, chômage). Activités de la vie quotidienne, loisirs.
 - Mode et lieu de vie (seul, en famille, en couple, en institution, sans domicile).
 - Entourage social et familial (nature des liens familiaux, nature des liens sociaux, relation sentimentale ou conjugale).
- **Antécédents médicaux et habitudes**
 - Rechercher les affections somatiques, les traitements médicaux (tous, corticoïde) actuels y compris psychotropes et les allergies.
 - Aborder la question de la consommation d'alcool, de tabac et d'autres toxiques : sevrage – intoxication
 - Addictions sans substance : jeux d'argent, gaming, réseaux sociaux, TCA, trouble du comportement sexuel

3. STATUS PSYCHIATRIQUE

- **A. Présentation, psychomotricité et contact relationnel**
 - Corpulence, tenue vestimentaire (soignée, négligée, neutre, excentrique), hygiène, posture, démarche, ralentissement, agitation, mimique.
 - Contact et relation
- **B. Troubles cognitifs**
 - Vigilance.
 - Orientation sur les 4 modes (temps, espace, à la situation, à sa personne).
 - Attention (focus attentionnel, partage le regard), concentration, mémoire.
- **C. Pensée et discours**
 - Ton (monotone, exalté), débit de parole (logorrhée, laconisme).
 - Cours de la pensée (accélération de la pensée, fuite des idées, réponses à côté, coqs à l'âne, désorganisé).
 - Contenu de la pensée (cohérence, logique, informations, thématique).
- **D. Délire, troubles du moi et des perceptions**
 - Idées prédélirantes, idées délirantes (thématique, systématisation, implication affective – est-ce qu'il y adhère ? – critique ?).
 - Déréalisation (=réel perçu comme irréel, comme un film), dépersonnalisation (se voit de l'extérieur), pensées imposées (automatisme mental).
 - Illusions, hallucinations (visuelles : poursuite oculaire, acoustico-verbales : attitude d'écoute, cénesthésiques, olfactives, gustatives), fréquence des hallucinations, participation affective, description
- **E. Thymie / humeur et affects**
 - Humeur abaissée - neutre - élevée, anhédonie, aboulie, manque de motivation, sentiment d'insuffisance, baisse de l'estime de soi, honte, culpabilité
 - Humeur émoussée, abrasée (perte d'émotion)
 - Affects congruents à l'humeur, discordance affective, labilité affective
- **F. Anxiété**
 - Tension interne, nervosité, agitation motrice
 - Obsessions, phobies (comportement d'évitement, hypervigilance), compulsions.
- **G. Idées suicidaires et hétéro-agressivité**
 - Volonté de se faire du mal, de mourir
 - Si oui : présence d'un scénario (accessibilité au moyen et létalité du moyen), imminence du scénario
- **H. Troubles somatiques et du dynamisme**
 - Troubles du sommeil, de l'appétence, gastro-intestinaux et cardio-respiratoires.

4. CONCLUSION DE L'ENTRETIEN

Dépression ECOS

Anamnèse

- Anamnèse actuelle :
 - Chronologie
 - Facteurs déclencheur couple
 - Facteur déclencheur professionnel
 - Facteur déclencheur solitude
- Anamnèse personnelle
 - Facteurs professionnels
 - Aspects financiers
 - Logements
 - Vie de couple
- Symptômes dépressifs majeurs :
 - Humeurs tristes
 - Anhédonie
 - Perte de l'élan vital ou fatigue
- DD bipolarité
 - ATCD d'humeur augmentée
 - Insomnie
 - Productivité augmentée
 - Logorrhée ou fuite des idées
 - Sensation de grandeur
 - Activité à risque
- Symptômes psychotiques
 - Hallucinations visuelles
 - Hallucinations auditives
 - Dépersonnalisation ou déréalisation
 - Devinement ou vol de la pensée
 - Délire paranoïde
- Troubles somatiques et caractérisations
- ATCD / comorbidités
 - Somatiques
 - Psychiatriques
 - ATCD TS
- Prise de substances
 - Médicaments
 - Drogues
 - Alcool
- Auto/hétéro-agression
 - Idées suicidaires
 - Risque suicidaire
 - Urgence : ou quand comment
 - Dangereux : létalité du moyen – accessibilité du moyen
 - Pensée à se faire du mal
 - Pensée à faire du mal à qq d'autres

Anamnèse sexuelle

Notions importantes

Possible de préciser au pt que on va aborder des questions un peu plus intimes

- Eviter préjugés (p.ex que les >70ans ont plus de rapport sexuel → >50% ont une vie sexuelle active)

1. Symptomes

- a. Douleurs, brulures à la miction
- b. Dyspareunies (douleur lors des rapports), vaginisme (contraction involontaire du périnée sur perturbation émotionnelle déclenchée devant toute perspective de pénétration)
→ peur, panique et contraction
- c. Prurit
- d. Boutons (sur le sexe, corps)
- e. ↓ EG, T°
- f. Dysfonction érectile
! peut être signe de MCV → y penser devant un tableau de DE + FRCV (DM, HTA, obésité, tabac, dyslipidémie)
- g. Notion de relation sexuelle non protégée/a risque

2. Questions clés (5'P)

- a. **Pratiques** : sexe oral, vaginal, anal et leurs perceptions
- b. **Partenaires** : homme, femme, multiples + nombre (combien de partenaires au cours des 3 derniers mois ?)
- c. **Protection**
 - i. Le pt sait-il de quoi elle le protège et de quoi elle ne protège pas ?
 - ii. Vaccins (hépatite, HPV) ?
- d. **Précédentes MST**
- e. **Prévention** : de la grossesse

3. Investigation

→ 3 types de trb sexuels

a. **Trb du DESIR**

i. **Anhedonie / manque 15%**

1. Trb sexuel ou autre pb du partenaire, sans cause et sans doléance
2. Trb psy
 - a. Dépression
 - b. Abus de substance
 - c. Burnout
 - d. Personnalité schizoïde
3. Après naissance d'un enfant (prolactine)
4. Maladies somatiques
 - a. Douleur
 - b. Affaiblissement divers
5. Effets secondaires du ttt
 - a. AD
 - b. Anti HTA
 - c. Chimiothérapie
 - d. Opérations
6. Contexte relationnel
 - a. Angoisse (de perf)
 - b. Pressions
 - c. Conflits relationnels

! Absence de désir (en general) → attention aux risques de suicide !

ii. **Aversion**

1. Degout
2. Injonctions massives durant le developpement
3. Traumatisme

iii. **Hypersexualité**

1. Manie
2. Trb borderline
3. Sex addiction
4. Medicament anti parkinsonniens
5. Rares causes somatiques (tumeurs cérébraux, hormonaux)

iv. TTT trb du désir (en cas de souffrance) = causal

1. Modif de la sexualité
2. Psychothérapie

b. **Trb de l'EXCITATION**

i. Femme

1. Manque de lubrification 15-30%
2. Fct psychiques (relationnels)
3. ↑ avec age car ↓ oestrogènes
4. F pdt ménopause 75%
5. TTT dyspareunie (douleur éprouvée pdt le rapport sexuel)
 - a. Substitution
 - b. Creme

ii. Homme

1. Pb d'érection
 - a. 40-70ans
 - i. 17% : léger
 - ii. 24% : moyen
 - iii. 10% : grave
2. Cause est souvent une **maladie somatique**
 - a. M vasculaire 33%
 - b. DM2 25%
 - c. Lésion ME 11%
 - d. Opération bassin 10%
 - e. Medic 8%

Ex. DE comme premiere manif d'une maladie coro
3. Majorité n'osent pas s'adresser au médecin
4. TTT = causal
 - a. Inhibiteur de la phosphodiesterase (Viagra)
 - b. Modif de la vie sexuelle

c. **Trb du PLAISIR** (avec souffrance associée)

i. Anorgasmie (10-20% des F)

1. Origines diverses (biologie, maladie, rapport au corps, besoin de contrôle, angoisses, conflits)

ii. Ejaculation précoce (primaire et secondaire), tadrive (moy 6min), anorgasmie

1. Ejaculation rétrograde
2. Peur

- 3. Addiction
- 4. Pornographie
- iii. Dyspareunie
 - 1. Somatique
 - 2. Psychique
 - 3. Traumatisme
- iv. Vaginisme
 - 1. Abus
 - 2. Peur de grossesse
 - 3. Lutte de pouvoir
- v. TTT
 - 1. Médicaments
 - 2. Spécialiste
 - 3. Éviter fiation

4. Symptômes

Symptôme → Caractéristiques → contexte relationnel → biographie

i. **Caractéristique du trb**

- 1. Contexte d'émergence du trb ?
Ex. Pdt travail ? Aussi pdt vacances ?
- 2. Fréquence trb ?
- 3. Durée ?
- 4. Intensité ?
- 5. Conséquences ?
- 6. Fct atténuants ? Fct aggravants ?

ii. **Contexte relationnel**

- 1. Partenaire ? Pratiques ? Conflits ?
- 2. Dynamique de couple ? Deregulation ?
- 3. Initiative ? Tendresse ?
- 4. Communication générale/sexuelle ?
- 5. Regard sur soi, son corps, autrui ?
- 6. Fantasmes ? Paraphilie ?
- 7. Représentations de la sexualité, préférences, aversions ?
- 8. Desir d'enfants, contraception ?
- 9. Situation sociale, autres domaines de partage ?

! un conflit conjugal commence souvent par la sexualité → indicateur très fin !

iii. **Biographie générale**

- 1. Contexte familial
 - a. Relation/sexualité (imaginée) des parents
 - b. Relation avec parents/autres rencontres significatives
 - c. Communication au sein de la famille/communauté
- 2. Contexte éducationnel, religieux, culturel
- 3. Événements de vie (traumatisants)
- 4. Maladies (FRCV), TTT, opérations, trb psy

iv. **Biographie sexuelle**

- 1. Préférence et orientation sexuelle
- 2. Développement sexuel, puberté

- a. Vécu des premières manif physiques, sexualité émergente
 - b. Climat familial
 - c. Masturbation
 - d. Traumatisme
 - e. Informations, communication
- 3. Communication sur la sexualité
 - 4. Premières exp sexuelles
 - 5. Satisfaction sexuelle
 - 6. Expériences relationnelles
 - 7. Contraception, désir d'enfants, grossesse, avortement
 - 8. Comportements à risques, IST
 - 9. Relations extraconjugales

5. Examen clinique

! Evoquer examen urogénital à l'ECOS, sans le faire !

DD perte de poids :

- **Cancer**
- **Hyperthyroïdie** (tremblements, palpitations, anxiété, sudation nocturne augmentation de l'appétit, intolérance à la chaleur, transpiration, tremblements, anxiété, tachycardie, diarrhée)
- **Insuffisance surrénalienne** (douleurs abdominales, fatigue, hyperpigmentation, étourdissements orthostatiques)
- **Diabète** (augmentation de l'appétit, polydipsie, polyurie)
- Troubles qui provoquent une **malabsorption**
- Dépression
- Anorexie
- Médicaments
- Toxicomanie

Dans certains troubles qui causent une perte de poids involontaire, d'autres symptômes ont tendance à être au premier plan, de sorte que la perte de poids n'est généralement pas la plainte principale :

Certains troubles de malabsorption: chirurgie digestive et mucoviscidose

- Troubles inflammatoires chroniques: polyarthrite rhumatoïde sévère
- Affections gastro-intestinales: achalasie, maladie cœliaque, maladie de Crohn, pancréatite chronique, troubles obstructifs œsophagiens, colite ischémique, entéropathie diabétique, ulcère gastroduodénal, sclérodermie progressive, rectocolite ulcéro-hémorragique (tardive)
- Troubles cardiaques et pulmonaires sévères chroniques: broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), insuffisance cardiaque (stade III ou IV), maladie pulmonaire restrictive
- Troubles mentaux (connus et mal contrôlés): anxiété, trouble bipolaire, dépression, schizophrénie
- Troubles neurologiques: sclérose latérale amyotrophique, démence, sclérose en plaques, myasthénie, maladie de Parkinson, accident vasculaire cérébral
- Problèmes sociaux: pauvreté, isolement social

DD prise de poids :

- **Cushing**
- **Hypothyroïdie**
- **Ovaire polykystique**
- Rétention hydrosodée :
 - Insuffisance cardiaque
 - Hépatopathie
 - Syndrome néphrotique